

Module 1 : Promotion et éducation à la santé

Concept de santé = « concept commun » au sens de Canguilhem (1988) → à portée de tous et affaire de chacun.
La perception dépend de : histoire perso, rapport au monde, contexte culturel & soc & éco & politique

Déterminants de la santé	Selon OMS « facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations ». Approche conceptuelle déclinée en plusieurs modèles : • Modèle de Dahlgren et Whitehead : + connu utilisé. Strates superposées ◦ Centre : individus, caractérisés par → âge, genre, facteurs constitutifs qui sont inchangeables ◦ Au dessus : comportements individuels (facteur de risque (tabac, alcool) qui affectent les personnes les plus fragiles) ◦ Strate suivante : influences de la société, communauté, réseaux sociaux ◦ Strate supérieure (principale source d'inégalité) : facteurs liés aux conditions de vie et de travail, accès aux ressources, aux infrastructures et services essentiels (++) syst scolaire) ◦ En dernier : conditions socioéco, culturelles et environnement => permet d'appréhender simplement la question des déterminants de santé. => toutes les strates (sauf sexe etc..) peuvent être touchées par l'action publique. - <u>dimension cumulative des dangers pour la santé</u> : populations fortement exposées à un facteur de risque ont tendance à cumuler d'autres facteurs de risque cercle vicieux quant à leur mauvais état de santé. - Montrent également comment une <u>forte exposition à des facteurs de risques pendant l'enfance</u> se traduit par une aggravation du risque de développer certaines maladies à l'âge adulte, ce qui amènera Berghmans, à ajouter au modèle la notion de trajectoire de vie. • Carte de la santé et ses déterminants : proposé dans le guide méthodo de mise en œuvre du parcours éducatif de santé. ◦ Cinq grands champs de déterminants : contexte global, systèmes, environnement, Caractéristiques individuelles, champ central (état de santé des pop) ◦ Champs sont perméables, en interaction et les liens ne sont pas unidirectionnels ◦ Analyse des déterminants doit se situer dans le temps et dans l'espace Ccl : - 2 modèles qui présentent les inégalités en matière de santé - Place stratégique de l'école - Santé = construit dynamique
Charte d'OTTAWA	
Compétences psychosociales	Les compétences « capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne » OMS 1993 "Les compétences psychosociales sont à considérer comme des outils d'adaptation cognitive, émotionnelle, comportementale permettant à un individu de faire face aux situations de la vie en respectant les autres et en collaborant avec eux" (Jacques Fortin) Classification d'origine par l'OMS (1993) en 10 catégories regroupées par binômes : • Savoir résoudre des problèmes / savoir prendre des décisions • Avoir une pensée créative / avoir une pensée critique • Savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles • Avoir conscience de soi / avoir de l'empathie • Savoir réguler ses émotions / savoir gérer son stress

Par la suite (depuis les années 2000), l'OMS a défini plus précisément les compétences psychosociales comme une aptitude psychosociale générale (OMS 1997) qui est *"la capacité d'une personne à maintenir un état de bien être subjectif qui lui permet d'adopter un comportement approprié et positif à l'occasion d'interactions avec les autres, sa culture et son environnement."*

CPS de l'OMS (2000) :

Compétences sociales	Compétences émotionnelles	Compétences cognitives
Communication (verbale ou non verbale) : écoute active, expression des émotions...	Compétences de régulation émotionnelle : gestion de la colère, anxiété...	Compétences de prise de décision et de résolution de pb
Capacité relationnelles : gestions des conflits, résolution pb relationnels...	Compétence de gestion du stress : gestion du temps, pensée positive....	Pensée critique et auto-évaluation : maîtriser influence pairs et médias...
Compétences de coopération	Compétences d'auto-évaluation et d'auto-régulation	
Compétence de plaider (persuasion et d'influence)		

Lorsque l'on veut développer des compétences psychosociales, on utilise plus souvent :

Compétences émotionnelles	Compétences cognitives	Compétences sociales
Connaître les émotions	S'auto-évaluer positivement	Communiquer de façon positive
Identifier les émotions	Savoir résoudre des pb	Dvper relations positives
Exprimer ses émotions		S'affirmer et résister à la pression sociale
Réguler ses émotions		Savoir résoudre des conflits

Vocabulaire :

En santé publique (prévention/promotion de la santé)

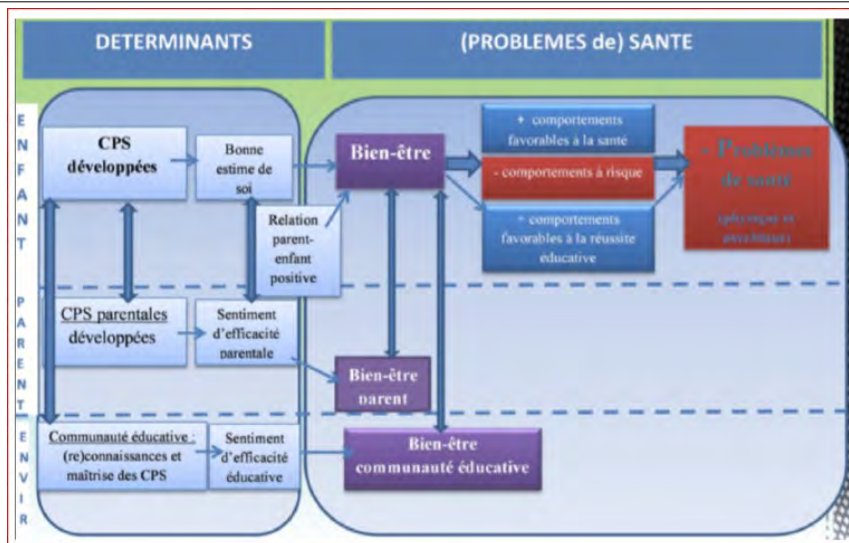
- Anglais : life skills, psychosocial compétences (OMS)
- Français : compétences psychosociales
- Récemment : social and emotional program (SEP)

En éducation (et psychoéducation)

- Anglais : social and emotional learning (SEL, CASEL)
- Français : compétences psychosociales ou compétences sociales et civiques (EN)

En psychologie (récemment) : compétences émotionnelles ou habileté sociale

CPS



	En prévention des addictions	Mikolajczak et al. ont développé un modèle qui comprend 10 compétences émotionnelles qui sont répartis en 5 compétence par rapport à ses propre émotions et 5 compétences par rapport aux émotions d'autrui. Ces compétences sont réparties de la manière suivante : - Capacité à identifier ses propres émotions, à identifier celles des autres. - Comprendre les émotions, c'est à dire que lorsque l'on éprouve une tension interne, il faut commencer par identifier de quoi il s'agit, de comprendre ce qui génère cette émotion. Implique une compétence <u>d'empathie</u>. - Exprimer ses émotions : Le fait d'exprimer ces émotions permettra ensuite d'agir sur la situation. Nécessite une régulation des émotions pour que l'intensité ne soit pas trop forte permette une communication efficace pour agir sur la situation. On peut aussi <u>apprendre à aider l'autre à réguler ses émotions</u>, notamment en écoutant. - Réguler ses émotions est la plus importante. en particulier dans les émotions difficiles tel que la colère pour pouvoir ajuster au mieux les comportement et les interactions. Il est aussi possible d'aider l'autre à réguler ses émotions . - Utiliser ses émotions pour prendre des décisions et faire des choix. On constate que la capacité à prendre en compte ses émotions peut orienter des actions et des prises de décision qui vont être plus en cohérence avec les valeurs de la personne, et les actions seront moins regrettées. <u>Utilité des CPS en prévention des addictions :</u> • Conso sont utilisées par une partie des jeunes pour mieux réguler les émotions et faciliter les relations → façon de s'adapter à des situations perçues comme difficiles (timidité // alcool et cigarette) • Peut aussi avoir un effet de diminution de l'intensité des émotions négatives ou diminution de la perception de ses émotions négatives (euphorie, détente) • « automédication » <u>Utilité de la régulation du stress et des émotions en prévention des addictions :</u> • FdR des addictions : ◦ forte réactivité émotionnelle ◦ intolérance à la frustration ◦ difficultés de régulation des émotions <u>Régulation dysfonctionnelle des émotions : Addictions :</u> • Difficulté de ses émotions = source de comportement addictifs • Substances utilisées pour : ◦ modifier expérience émotionnelle (+ positive) ◦ éviter de ressentir émotions négatives ◦ remplacer émotions par des sensations • Utilité de l'apprentissage de techniques de régulation et d'acceptation des émotions : diminue tendance à utiliser produits <u>Déficit de compétences relationnelles (affirmation de soi) :</u> • Risque en terme d'abus de substances, d'addictions et de tb alimentaires • Dvper K capacité à négocier, refuser, argumenter
--	---------------------------------------	--

Les interventions CPS validées	De quoi parle-t-on ?	Validation se fait par un cycle d'atelier, chaque atelier apporte 1 CPS (avec un manuel pour l'intervenant et un livret pour le participant) et dans la durée : séance hebdo de 1 à 2h, min 10 séances (pluriannuel pour les enfants). Intervention validée lorsque : • Précise avec manuel+livret • Efficacité démontrée par au moins 2 équipes de recherches différentes, indé avec des Essais Contrôlés Randomisés ou une étude comparative quasi-expérimentale
	Effets sur la santé ?	Effets finaux : • Santé mentale : moins de tb affectifs et de comportement, meilleur bien-être • Conduites à risques : moins de conso de substances, violence, harcèlement scolaire... • Réussite éducative et pro : meilleurs résultats, moins d'échec sco... Effets intermédiaires sur les déterminants de la santé : • Dvpt des CPS • Meilleure estime de soi • Meilleures relations Caractéristiques des interventions CPS validées (efficace) - Reproduction des conditions naturelles d'apprentissage des compétences (psychosociales) : expérience, observation, imitation (comme le ferait un jeune enfant) - Des méthodes pédagogiques interactives et expérientielles (et non des cours théoriques) - Des adultes qui ont développé les CPS eux-mêmes ↔ processus de modeling- Des CPS choisies en fonction du problème de santé :- Ex de addictions : régulation des émotions, affirmation de soi - Ex santé sexuelle : négociation, affirmation de soi, résolution de problème- Ex violence : empathie, régulation des émotions (colère) - Des ateliers formels structurés (pour permettre la reproduction) - Des pratiques informelles répétées : pendant la journée, dans différents milieux (école, famille, communauté...) - Des interventions articulées avec les autres interventions proposées dans les établissements scolaires par exemple - Environnement constructif : prévention du harcèlement, activités favorisant les relations positives
	Exemples d'interventions	• Programme Strengthening Families Program (Kumpfer ◦ addictions avec 3 différents supports → parents, enfants, famille • Programme Unplugged <u>Liens entre inégalités sociales et santé</u> Inégalités sociales = inégalités de conditions de vie (dans la société) et génèrent inégalités sociales de santé qui amplifient inégalités sociales. • Catégorie sociopro et espérance de vie : ◦ importantes inégalités entre Ktgories → ne baissent pas malgré une amélioration du niveau moyen de l'état de santé ◦ => espérance de vie à 35 ans ◦ femmes vivent plus longtemps que les hommes et les écarts entre les catégories socioprofessionnelles sont moins important que chez les hommes ◦ L'« espérance de vie sans incapacité » est d'autant plus réduite pour les catégories sociales défavorisées. • Niveau d'étude ◦ Plus le niveau de diplôme est élevé moins les risques annuels de mortalité sont importants • Inégalités sociales de santé des enfants ◦ Les inégalités sociales de santé présentes à l'âge adulte s'observent également dès le plus jeune âge ◦ Enfance = période particulière en termes de santé car un grand nombre d'habitudes y sont acquises

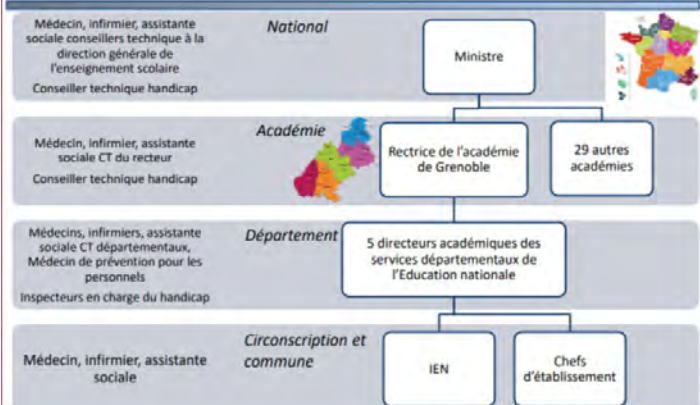
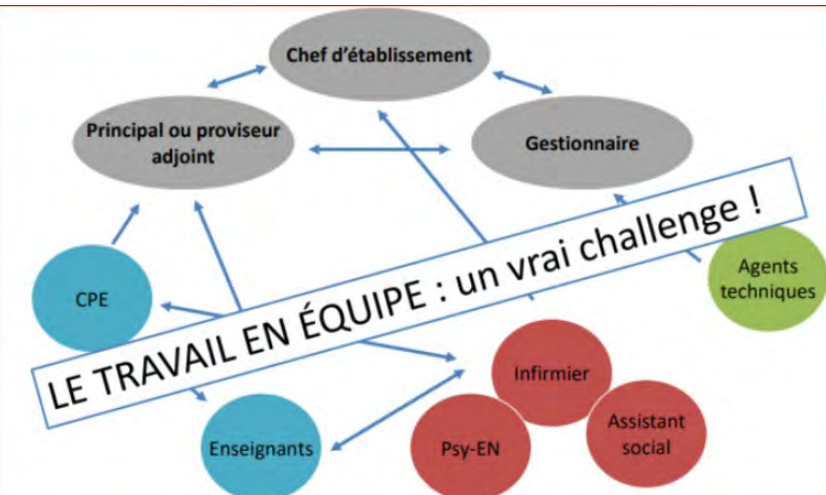
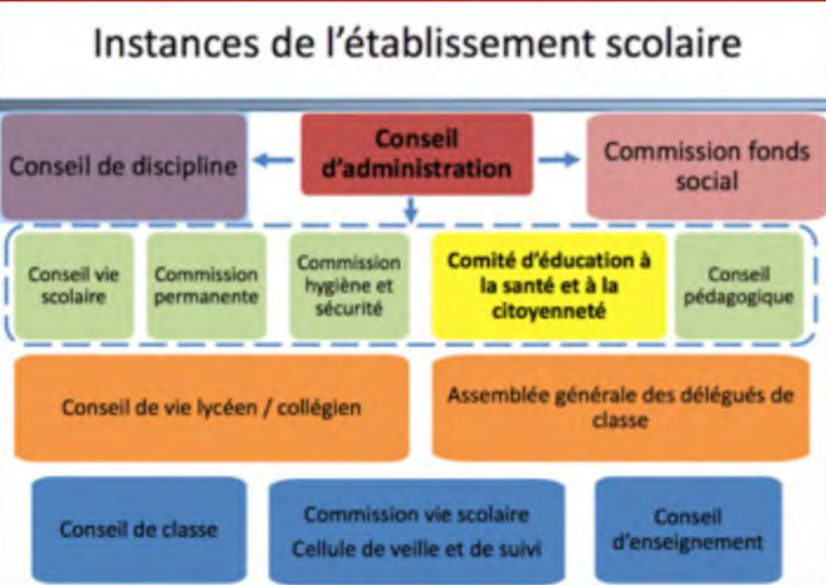
	◦ fortes disparités selon la catégorie sociale : ▪ Santé bucodentaire : excellent marqueur ▪ Obésité : touche inégalement les catégories sociales, les sexes et les zones géographiques ▪ Santé mentale : inégalités liées à la position dans la hiérarchie sociale. L'étude de suivi GAZEL montre qu'un faible statut socio-économique rend prévisible une dépression à long terme												
Evolution historique des approches et modèles en éducation à la santé	En relation avec l'évolution de : conceptions de la santé, contexte, pratiques pédago 1ère moitié du XXe siècle : parle pas encore d'éducation • 2 fléaux : alcoolisme et maladies infectieuses (tuberculose) • Dvpt courants hygiénistes → hygiène médicale et domestique et poussent dans les écoles à l'instauration de leçons de morale pour enseigner bonnes conduites et celles à éviter. 2ème moitié du XXe siècle : limites de l'approche hygiéniste (jugements moraux) • Nouvelle approche se dvpt autour de la nécessité d'informer et prévenir • Généralisation du courant en 1969 Concept de promotion de la santé s'inscrit dans la charte d'Ottawa est modélisée par Downie et Tannahil, 3 pôles : • Prévention : « l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre ou la gravité des maladies ou accidents » ◦ prévention primaire intervient avant l'apparition des maladies ou accidents. Elle a pour but d'en-réduire le risque de survenue. ◦ prévention secondaire intervient au tout début de la maladie. Elle vise à éviter sa progression, à limiter le nombre de malades en réduisant la durée d'évolution de la maladie. Elle s'appuie sur le dépistage précoce et le traitement des premières atteintes. ◦ prévention tertiaire intervient lorsque la maladie est bien installée. Elle vise à prévenir les récurrences dans une population et aide les personnes concernées à vivre au mieux avec les incapacités éventuelles consécutives à la maladie. • Protection : créer un environnement favorable à la santé. Diminuer la probabilité, pour les personnes, de rencontrer des risques dans leur environnement, ou d'adopter des comportements néfastes à leur santé, tout en augmentant leurs chances de vivre dans un environnement sain. (règles, codes, lois) • Education : l'émergence d'un sujet capable de prendre du pouvoir sur sa vie c'est-à-dire capable de se positionner par rapport à des savoirs et des pratiques relatifs à la santé, capable de faire des choix et d'adopter des comportements responsables 2 modèles principaux de santé s'opposent : médical (maladie) vs global (prend en compte dimensions biologique, affective et sociale). Cet antagonisme débouche sur différents modèles d'éducation à la santé : <table><tr><th>Rationnel</th><th>Humaniste</th><th>Dialectique sociale</th><th>Ecologique</th></tr><tr><td>Centré sur : - La maladie - Le risque - La transmission des connaissances</td><td>Centré sur : La personne</td><td>Centré sur : Les rapports de l'homme à son environnement</td><td>Centré sur : La personne et les interrelations avec l'environnement</td></tr><tr><td>Objectif : Un changement de comportements</td><td>Objectifs : - Réalisation de soi - Bien-être - Autonomie => Comportements choisis</td><td>Objectif : Maîtriser son existence dans son groupe et mieux contrôler son environnement</td><td>Objectifs : - Développement intégral de la personne - Accompagnement de la personne</td></tr></table>	Rationnel	Humaniste	Dialectique sociale	Ecologique	Centré sur : - La maladie - Le risque - La transmission des connaissances	Centré sur : La personne	Centré sur : Les rapports de l'homme à son environnement	Centré sur : La personne et les interrelations avec l'environnement	Objectif : Un changement de comportements	Objectifs : - Réalisation de soi - Bien-être - Autonomie => Comportements choisis	Objectif : Maîtriser son existence dans son groupe et mieux contrôler son environnement	Objectifs : - Développement intégral de la personne - Accompagnement de la personne
Rationnel	Humaniste	Dialectique sociale	Ecologique										
Centré sur : - La maladie - Le risque - La transmission des connaissances	Centré sur : La personne	Centré sur : Les rapports de l'homme à son environnement	Centré sur : La personne et les interrelations avec l'environnement										
Objectif : Un changement de comportements	Objectifs : - Réalisation de soi - Bien-être - Autonomie => Comportements choisis	Objectif : Maîtriser son existence dans son groupe et mieux contrôler son environnement	Objectifs : - Développement intégral de la personne - Accompagnement de la personne										

	Education à la santé et dvpt des CPS	Dvper la maitrise de compétences fait partie des missions de l'Ecole 1. <u>Avoir conscience de soi/avoir de l'empathie pour les autres</u> donne de l'assurance dans les relations avec les autres (ouverture), permet d'éviter attitudes relationnelles négatives. 2. <u>Savoir gérer son stress / ses émotions :</u> permet de réagir de manière appropriée et tirer parti du potentiel positif qu'offre le stress. Exerce la sensibilité, a perception de ses propres émotions et permet de composer avec elles. Améliore expression orale 3. <u>Savoir communiquer efficacement/ être capable d'établir des relations interpersonnelles</u> favorise l'expression de soi (pensées, émotions) et la gestion de conflits éventuels. mobilisées lorsqu'il s'agit de se positionner face aux influences du groupe 4. <u>Avoir une pensée critique/créative</u> pensée créative aide à regarder au-delà de sa seule expérience L' esprit critique permet de donner du sens aux actions, de questionner les représentations ou les croyances avant de prendre parti 5. <u>Savoir résoudre des problèmes/prendre des décisions</u> La résolution de problème consiste en l'énumération des différents moyens de répondre à une situation problématique, en formulant des hypothèses et en analysant leurs conséquences <u>Liens entre CPS et comportements de santé :</u> La capacité à modifier un comportement pour qu'il soit moins préjudiciable à sa santé relève d'un processus complexe. La prise en compte de l'ensemble des facteurs, susceptibles de changer ce comportement relève de la compétence « savoir résoudre des problèmes ». Quelle que soit la thématique de santé envisagée, objectiver ses agissements, analyser, hiérarchiser les causes, envisager les conséquences et pour finir prendre une décision = déterminants essentiels d'une évolution comportementale.
	Questionnements éthiques	Les actions d'éducation à la santé sont par essence des interventions sur la personne humaine à la fois dans sa dimension biologique, psychologique et sociale. Réflexion éthique en éducation à la santé repose sur 4 principes fondamentaux : • « Faire du bien » • « Respect de l'autonomie des personnes » • « Ne pas faire du mal » • « La justice » : égalité Déterminants multiples → penser à tous les inclure ! • Liés à l'individu : habitudes de vie, psychologie... • Liés à l'env immédiat : famille, école, travail, milieux de vie, env physique • Liés à env global : valeurs sociales et culturelles, env politique, condi° éco. Risque de culpabilisation et de stigmatisation : • lorsque la responsabilité perso est mise en avant au détriment du reste Risque de conflit de valeurs : • actions véhiculent des messages qui peuvent heurter la culture ou la religion des pop auxquelles il s'adressent. Ethique et légitimité des actions : • Vouloir changer les comportements est une lourde responsabilité. Au nom de quoi intervient-on ? Risque de la normalisation : • Peu de place pour l'expression de la diversité (++) nutrition) Risque de dramatisation (passage à l'acte) Risque de manipulation (peut être négatif → déni, évitement) Risque d'accroissement des inégalités de santé

	Gérer un projet de prévention Projet = intention ou décision d'agir • Une action, un plan d'action, un programme • Initié par un commanditaire (la demande) réponse La gestion de projet = démarche méthodologique visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d'un projet. Bonne pratique de la gestion de projet = modèle CORSE → éléments essentiels d'un projet : • Calendrier • Objectifs • Responsable • Suivi du projet • Evaluation <u>Etapas d'un projet :</u> - L'étape la plus importante = définir <u>clairement les objectifs</u> du projet. • Population cible : qui, combien • Objectif général : le but à atteindre, la finalité, répond à la demande du commanditaire. • Objectifs spécifiques : guident le plan d'action sensibiliser, informer, former, combattre des idées fausses... • Objectifs opérationnels : les choses à faire supports d'information (affiches...), atelier de réflexion (vidéos, outils d'animation...)... - <u>Désigner un responsable</u> = un chef de projet (coordonnateur du groupe qui pilote le projet). - <u>Affecter les ressources si nécessaire</u> : collaborateurs = groupe projet, temps, moyens. - <u>Calendrier</u> : inscrire les tâches dans le temps, et fixer une date de fin en accord avec le commanditaire, compatible avec les tâches à accomplir et modulable en fonction des difficultés rencontrées. - <u>Suivi de projet</u> : • Interne : par le chef de projet. • Externe : commanditaire, qui vérifie l'avancement, qui soit être informer des difficultés/obstacle pour adapter les ressources si nécessaire. - <u>Diagramme de Gantt</u> = un outil de planification et de suivi du projet permet d'identifier et d'inscrire les tâches dans un calendrier. - <u>Evaluation</u> = vérifier que les objectifs ont été atteints. • Objectifs opérationnels (facile) : ateliers faits, supports diffusés... • Objectifs généraux (plus difficile : difficile de mesurer le résultat final du projet on se sert de l'évaluation de critères intermédiaires dont on suppose qu'ils sont associés au résultat final + de critères de résultat. <u>Conclusion :</u> - Pour gérer un projet il faut du bon sens et de la rigueur - Commencer par un diagnostic : définir l'objectif général (la finalité) et les objectifs opérationnels - Organiser le suivi du projet selon un calendrier prévisionnel - Définir l'évaluation de l'atteinte des objectifs dès le début du projet
--	--

MODULE 2

CHAP 1 : PROMOTION, EDUCATION à LA SANTE → ROLE DE L'EDUCATION NATIONALE

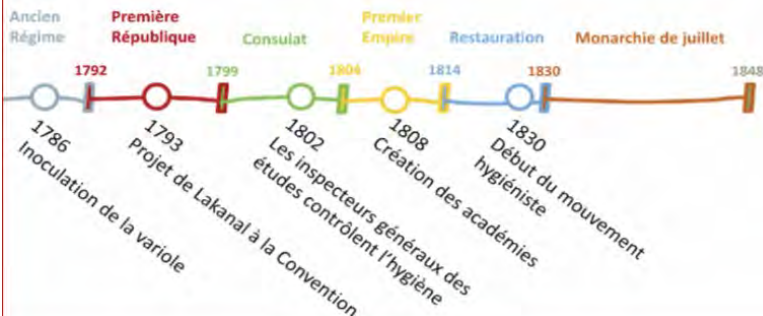
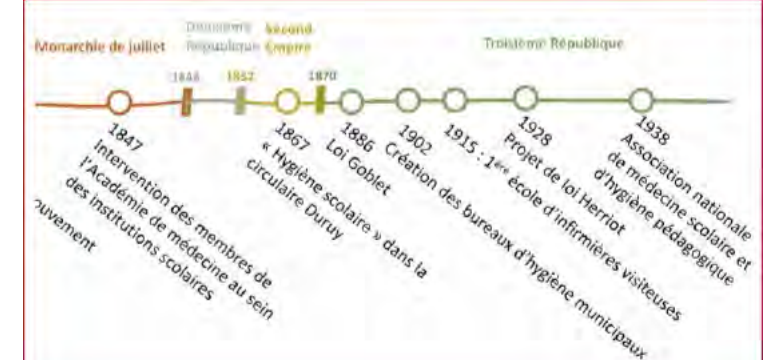
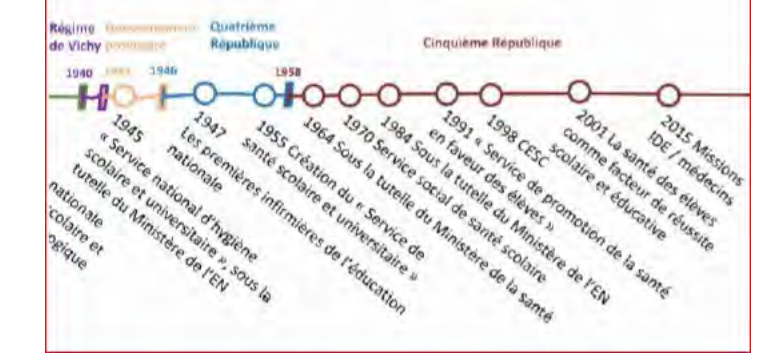
Organisation	Education Nationale	 National Ministre Médecin, infirmier, assistante sociale conseillers technique à la direction générale de l'enseignement scolaire Conseiller technique handicap Académie Rectrice de l'académie de Grenoble 29 autres académies Médecin, infirmier, assistante sociale CT du recteur Conseiller technique handicap Département 5 directeurs académiques des services départementaux de l'Education nationale Médicins, infirmiers, assistante sociale CT départementaux, Médecin de prévention pour les personnels Inspecteurs en charge du handicap Circonscription et commune IEN Chefs d'établissement Médecin, infirmier, assistante sociale
	Etablissement scolaire	Au centre d'un écosystème vaste Avec 6 acteurs différents :  LE TRAVAIL EN ÉQUIPE : un vrai challenge ! Et de nombreuses instances :  Instances de l'établissement scolaire Conseil de discipline, Conseil d'administration, Commission fonds social Conseil vie scolaire, Commission permanente, Commission hygiène et sécurité, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, Conseil pédagogique Conseil de vie lycéen / collégien, Assemblée générale des délégués de classe Conseil de classe, Commission vie scolaire Cellule de veille et de suivi, Conseil d'enseignement Les parcours des élèves sont aux nombres de 4: 1) en lien avec l'éducation à l'orientation et l'insertion professionnel 2) le parcours d'éducation artistique et culturelle 3) le parcours citoyen, visant à développer l'engagement + l'éducation à la démocratie 4) le parcours éducatif de santé

Compétences et valeurs communes	• A tous les acteurs du service public d'éducation : ◦ faire partager les valeurs de la République ◦ S'inscrire dans les principes fondamentaux du syst éducatif ◦ Agir dans le cadre réglementaire de l'école • → 4 principes : ◦ liberté d'enseignement (liberté d'expression – loi 31 décembre 1959) ◦ la gratuité (loi 16 juin 1881) ◦ neutralité (laïque depuis 1882 + laïcité de l'État 1905) ◦ obligation scolaire (Loi Jules Ferry 1882) • Aux professeurs, personnels, pédagogues et éducateurs ◦ connaître processus d'apprentissage ◦ Prendre en compte la diversité des élèves ◦ agir de manière éthiques • Aux professeurs et personnels d'éducation : ◦ coopérer au sein d'une équipe ◦ coopérer au sein d'une communauté éducative
Intervenir devant les élèves	• Préparer l'intervention et l'inscrire dans le contexte de de l'établissement • Assurer un climat d'apprentissage bienveillant • Favoriser la mise en activité des élèves <i>De commencer par se présenter, dites pourquoi vous êtes dans la classe et avec les élèves, et ce que vous allez faire pendant le temps qui vous est imparti. Un bon intervenant est quelqu'un qui parle peu et qui sait provoquer la parole chez les jeunes. Si les élèves parlent tous en même temps, continuez de parler mais moins fort pour faire revenir le calme. Si une classe commence à chahuter, allez vers celui qui chahute, votre présence à proximité calmera son activité. Le professeur présent avec vous saura également intervenir. Que faire avec le tableau? Quels supports? Ce sont des questions à se poser lors de la construction de l'intervention. Ne conversez pas seul avec une personne, adressez vous au groupe, regardez tout le monde, bougez, déplacez vous. Demandez au chef d'établissement comment ça se passe dans son collège, s'adapter aux codes, faut il que les élèves vous appellent par votre prénom, ou par Monsieur ou par Madame. Vous devez capter tous les regards des élèves, apportez tout ce que vous voulez pour faire du sens, vidéos, images, textes, revues. Privilégiez la mise en activité des élèves plutôt que la transmission de contenu.</i>
Parcours de formation	Au coeur des 4 parcours : bien-être physique, mental, social Promotion de la santé : • Faire acquérir à chaque élève connaissances, compétences et culture pour prendre en charge sa propre santé • mettre en œuvre des projets de prévention sur les problématiques de santé dans une logique sur de parcours • Créer un env scolaire favorable à la santé et la réussite scolaire
Universalisme proportionné	• Offrir une intervention à tous, mais avec des modalités ou une intensité qui varient selon les besoins • Individualisation des parcours • Egalité =/ équité (<i>c'est effectivement adapter la réponse aux besoins des élèves, et c'est ce que nous nous efforçons de faire à travers la réponse en santé que nous apportons aux élèves. A la fois au niveau de tous ce qui est protection, bilan de santé et à la fois ce qui est des réponses au niveau de l'éducation à la santé et des réponse autour du parcours éducatif de santé.</i>)

CHAP 2 : ECOLE ET SANTE

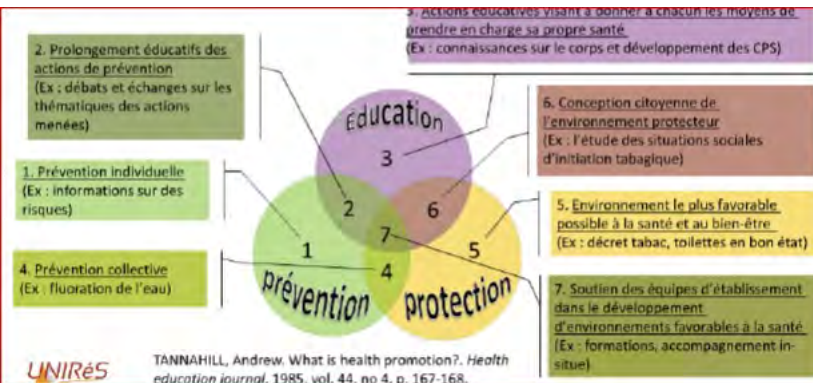
Lien santé et réussite scolaire	L'éducation a un impact majeur sur la santé & la bonne santé induit une meilleure réussite sco																						
	Projet éducatif de santé Représentations de la santé et de l'éducation Choix Revenir aux pratiques • Objectifs • Approches pédagogiques • Outils d'animation • Partenaires • Modalités d'intervention • Prendre conscience des limites du champ de validité des modèles • Identifier les modèles les plus pertinents et efficaces en fonction du contexte d'action																						
Modèles de santé	Linéaire / Biomédical	- Santé est définie comme l'état contraire de la maladie = considérée comme un accident de la vie qui vient en limiter la durée et peut conduire à la mort, qui représente alors un échec thérapeutique. - Selon cette conception, l'homme se positionne ainsi sur un axe opposant santé et mort. Cette conception est de nos jours encore très présente et il convient d'en sortir.																					
	Global	« La santé est un état de complet bien-être physique, social et mental et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. » OMS, 1946 • plusieurs dimensions • une vision positive de la santé • sentiment de bien-être en relation avec la satisfaction des besoins de l'individu. La santé, c'est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d'autre part, évoluer avec son milieu et s'adapter à celui-ci. OMS, 1982																					
	D'un sujet autonome ouvert sur le monde	- La condition essentielle : l'émergence du Sujet libre en capacité de faire des choix - Le sujet « n'est pas seulement acteur de sa santé, mais en tant que sujet autonome, il devient partenaire des soins de santé avec les professionnels de la santé » Eymard 2004																					
Modèles d'éducation à la santé	<table><tr><td></td><th colspan="3">Modèles de santé</th></tr><tr><th>Modèles éducatifs</th><th>Linéaire - Absence de maladie - Approche hygiéniste ou biomédicale </th><th>Global - Adaptation individuelle ou ajustement social - Approche biopsychosociale </th><th>Sujet autonome ouvert sur le monde</th></tr><tr><td>Instruction</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Développement du sujet</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interaction sociale</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Modèles de santé			Modèles éducatifs	Linéaire - Absence de maladie - Approche hygiéniste ou biomédicale	Global - Adaptation individuelle ou ajustement social - Approche biopsychosociale	Sujet autonome ouvert sur le monde	Instruction				Développement du sujet				Interaction sociale			
	Modèles de santé																						
Modèles éducatifs	Linéaire - Absence de maladie - Approche hygiéniste ou biomédicale	Global - Adaptation individuelle ou ajustement social - Approche biopsychosociale	Sujet autonome ouvert sur le monde																				
Instruction																							
Développement du sujet																							
Interaction sociale																							
Actions de prévention des conduites addictives à destination d'adolescents																							

CHAP 3 : HISTOIRE DE LA SANTE SCOLAIRE

Première moitié du XIXème siècle > Le mouvement hygiéniste  Ancien Régime, Première République, Consulat, Premier Empire, Restauration, Monarchie de juillet 1786 Inoculation de la variole 1792 1793 Projet de Lakanal à la Convention 1799 1802 Les inspecteurs généraux des études contrôlent l'hygiène 1804 1808 Création des académies hygiénistes 1814 1830 Début du mouvement hygiéniste 1848	Projet de Lakanal : « projet d'éducation du peuple français »
La Troisième République > Projet de loi Herriot  Monarchie de juillet, Deuxième République, Troisième République 1847 Intervention des membres de l'Académie de médecine au sein du mouvement 1848 1857 « Hygiène scolaire » dans la circulaire Duruy 1867 Loi Goblet 1870 1902 Création des bureaux d'hygiène municipaux 1915 : 1ère école d'infirmières visiteuses 1928 Projet de loi Herriot 1938 Association nationale de médecine scolaire et d'hygiène pédagogique	Loi Goblet : confie aux médecins communaux ou départementaux, la mission de visiter les écoles primaires. Infirmières visiteuses : création de la spécialité « infirmière d'hygiène scolaire » en 1926 → secondent le médecin en tenant des fiches médicales des enfants et en surveillant poids et mensurations Loi Herriot : obligation du contrôle médical pour tous les élèves et les personnels
Sous la Cinquième République > Les missions  Régime de Vichy, Quatrième République, Cinquième République 1940 1941 1946 1945 « Service national d'hygiène scolaire et universitaire » sous la tutelle du Ministère de l'EN 1947 Les premières infirmières de l'éducation nationale 1955 Création du « Service de santé scolaire et universitaire » 1964 Sous la tutelle du Ministère de la Santé 1970 Service social de santé scolaire 1984 Service de promotion de la santé en faveur des élèves 1991 « Service de santé scolaire » 1998 CESC 2001 La santé des élèves comme facteur de réussite scolaire et éducative 2015 Missions IDE / médecins	1945 : visite médicale obligatoire et contrôle des vaccinations obligatoires pour tous les enfants de 6 ans 1964 : transfert des services sociaux et médicaux du Ministère de l'Education Nat au Ministère de la Santé Publique 1984 : inverse

CHAP 4 : PARCOURS EDUCATIF DE SANTE

- Loi de refondation de l'école 2013
- Tous les élèves → maternelle au lycée
- Construction progressive des connaissances et des compétences nécessaires
- 3 axes : éducation, prévention, protection (interdiction de fumer au sein de l'établissement)



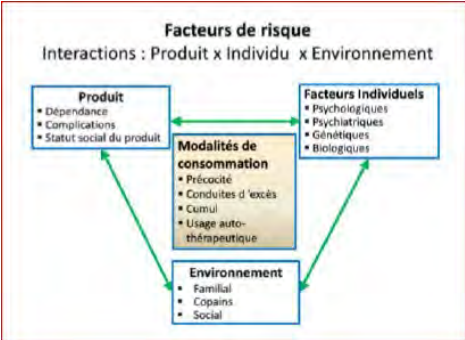
Une modélisation :

- à adapter au contexte
- d'aide au pilotage
- d'aide au diagnostic
- de support de communication

Domaines	Objet	Exemples
Domaine 1	Mesures de prévention individuelle destinées à empêcher l'apparition de la maladie.	Les informations délivrées sur les risques).
Domaine 2	Prolongements éducatifs des actions de prévention menées.	Débats sur les thématiques de santé, théâtre etc..).
Domaine 3	Actions éducatives visant à donner à chacun les moyens de prendre en charge sa propre santé . Ancrées sur le socle, les programmes disciplinaires, l'enseignement moral et civique ou encore les enseignements pratiques interdisciplinaires, ces actions éducatives visent toutes à la fois l'apport de connaissances sur le corps, ses besoins, les risques, mais aussi le développement des compétences psychosociales.	
Domaine 4	Mesures de prévention collective	- Fluoruration de l'eau pour prévenir les caries dentaires - Composition équilibrée des repas à la cantine
Domaine 5	Inclut des actions visant à protéger les individus des maladies afin d'offrir un environnement le plus favorable possible à la santé et au bien-être.	Interdiction de fumer dans les lieux publics, rénovation des toilettes publiques.
Domaine 6	S'intéresse à la conception citoyenne de l'environnement protecteur . La réflexion éducative sur les mesures collectives en fait partie.	Étude des situations sociales d'initiation tabagique.
Domaine 7	Clef de voute du système : actions de soutien des équipes d'établissements dans le développement d'environnements favorables à la santé.	

MODULE 3

CHAP 1 : ADDICTION ET CONDUITES ADDICTIVES : DEF, NEUROBIOLOGIE

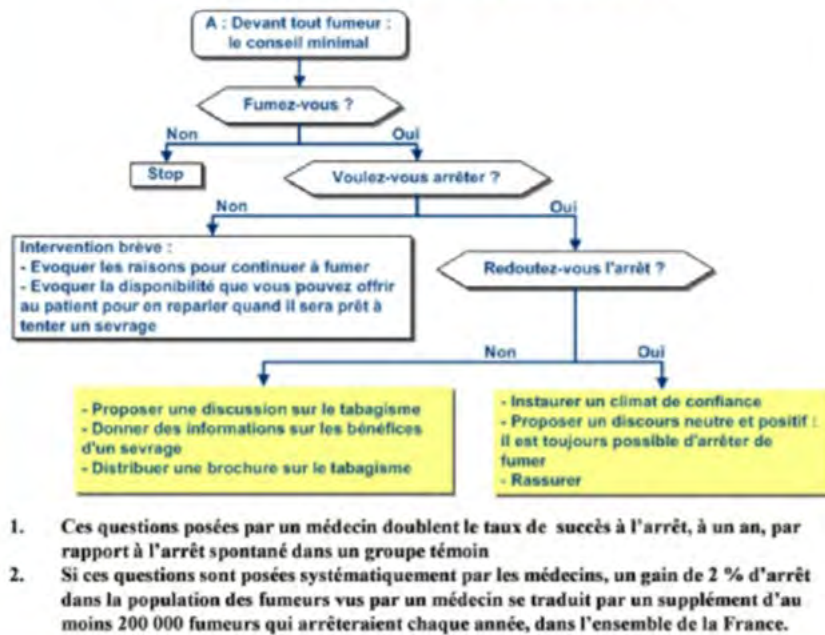
Intro	- Comportement visant à produire du plaisir ou écarter une sensation de malaise interne - Répétition - Perte de contrôle - Usage malgré les effets nocifs Dépendance : - psychique : « craving » = envie irrépressible induisant à recherche compulsive du produit - physique : « tolérance » = besoin de doses augmentées, « Sd de sevrage » = si manq Conso de substance psychoactive : - Licite : alcool, tabac, chique, médocs psychotropes - Illicite : cannabis, héroïne, cocaïne, amphét, hallucinogène ... Conduite addictive sans produit : - jeu d'argent, jeu vidéo, sport patho, boulimie, addiction sexuelle, achats compulsifs, work, smartphones	
Description	Approche catégorielle	- Usage simple : ni à risque, ni nocif, ni dépendant - Usage à risque : seuil de risque mais pas nocif - Usage nocif : existe au moins un effet nocif - usage dépendant : existe des signes DSM4 de dépendance : psy ou physiq
	Approche dimensionnelle	Trouble de l'usage de substances DSM5 - Craving - Dimension de gravité - Sujet présente une addiction plus ou moins grave selon le nb de symptômes sur 11 items regroupant l'abus et la dépendance Dans le DSM5, le trouble de l'usage est coté « absent » en dessous de 2 critères, puis l'addiction évolue de « légère » (2 à 3 critères) à sévère (+ de 6 critères).
	 Facteurs de risque Interactions : Produit x Individu x Environnement Le diagramme illustre les interactions entre quatre domaines : Produit : Dépendance, Complications, Statut social du produit Facteurs Individuels : Psychologiques, Psychiatriques, Génétiques, Biologiques Environnement : Familial, Copains, Social Modalités de consommation : Précocité, Conduites d'excès, Cumul, Usage auto-thérapeutique Des flèches vertes indiquent des interactions bidirectionnelles entre le Produit et les Modalités de consommation, entre les Facteurs Individuels et les Modalités de consommation, et entre l'Environnement et les Modalités de consommation.	
Syst de la récompense	- Recherche de plaisir et d'évitement de la souffrance - Réponse aux besoins fondamentaux - Les désirs-plaisirs naturels activent les neurones dopaminergiques - La dopamine code la valeur du plaisir - le comportement acquiert une signification motivante, de « récompense » Les structures concernées sont : - l'aire tegmentale ventrale - noyau accumbens - cortex préfrontal - Structures limbiques : amygdale (émotions) et hippocampe (mémoire)	

	À l'état normal, il n'y a pas d'emballement de la recherche de récompense du fait : 1. du fonctionnement en feed-back, c'est-à-dire du fait que l'obtention d'un résultat favorable supprime la stimulation 2. De l'élimination de la dopamine 3. De l'intégrité de la voie inhibitrice cortico-frontale L'individu conserve donc des ressources de satisfaction et de soulagement variées. Drogue = leurre pharmacologique (réponse de dopamine plus élevé que la nourriture) Dans l'addiction, la poursuite de consommation du produit va aboutir : • Au phénomène d'accoutumance (la personne va ressentir de moins en moins de satisfaction ce qui peut entraîner une accélération du comportement) • Au craving positif axé sur la recherche de plaisir • Au craving négatif axé sur l'évitement plus ou moins conscient de la souffrance puis du manque • A la perte de contrôle de la consommation de produit ou du comportement • Puis au syndrome de sevrage variable selon les substances du fait de la complexité de leurs actions On a prouvé que certains comportements suractivent aussi la dopamine ou les endorphines tel que le jeu d'argent, la compétition sportive, etc.. Certaines substances psychoactives se greffent sur les récepteurs présynaptiques dédiés à des neuromédiateurs naturels, comme les récepteurs endorphiniques, nicotiniques, endocannabinoides, d'autres bloquent dans l'espace intersynaptique la recapture de la dopamine entraînant une accumulation de celle ci. Il existe des addictions croisées, une substance interagissant alors avec la sensibilisation du récepteur d'un autre produit. Toutes les substances addictives ont donc en commun un effet dopaminergique <u>Dans le cerveau d'un addict</u> : perte du contrôle cortical dû à l'altération du cortex préfrontal et de la puissance de l'effet de renforcement									
La société	Une société « addictogène » <table><tr><th colspan="2">Les conduites addictives à la frontière du 'normal' et du 'pathologique'</th><th>Société addictogène</th></tr><tr><td>Les dérives admises:</td><td>Ce qui est dénoncé:</td><td></td></tr><tr><td> • Alcoolisation sociale • Dopage même au travail • Médicaments psychotropes • Boissons énergisantes • Internet, smartphone • Hyperactivité promue par les medias • Addiction au sport • Musculation </td><td> • Alcoolisme • Tabagisme • Médicaments psychotropes • Cocaïne • Cannabis • Drogues de synthèse • Jeux , cyberaddiction • Dopages </td><td> • Hyperconsommation, loi de l'offre et de la demande • course à la performance • 'tout tout de suite' , réponses instantanées et individuelles • recherche de sensation, besoin d'intensité • pression, stress au travail, précarité • Être cool à tout prix, refuser l'anxiété • Recherche d'anesthésie • Eviter la relation à l'autre, éviter les conflits • Auto-administration rapide des plaisirs et soulagements par divers produits... </td></tr></table>	Les conduites addictives à la frontière du 'normal' et du 'pathologique'		Société addictogène	Les dérives admises:	Ce qui est dénoncé:		• Alcoolisation sociale • Dopage même au travail • Médicaments psychotropes • Boissons énergisantes • Internet, smartphone • Hyperactivité promue par les medias • Addiction au sport • Musculation	• Alcoolisme • Tabagisme • Médicaments psychotropes • Cocaïne • Cannabis • Drogues de synthèse • Jeux , cyberaddiction • Dopages	• Hyperconsommation, loi de l'offre et de la demande • course à la performance • 'tout tout de suite' , réponses instantanées et individuelles • recherche de sensation, besoin d'intensité • pression, stress au travail, précarité • Être cool à tout prix, refuser l'anxiété • Recherche d'anesthésie • Eviter la relation à l'autre, éviter les conflits • Auto-administration rapide des plaisirs et soulagements par divers produits...
Les conduites addictives à la frontière du 'normal' et du 'pathologique'		Société addictogène								
Les dérives admises:	Ce qui est dénoncé:									
• Alcoolisation sociale • Dopage même au travail • Médicaments psychotropes • Boissons énergisantes • Internet, smartphone • Hyperactivité promue par les medias • Addiction au sport • Musculation	• Alcoolisme • Tabagisme • Médicaments psychotropes • Cocaïne • Cannabis • Drogues de synthèse • Jeux , cyberaddiction • Dopages	• Hyperconsommation, loi de l'offre et de la demande • course à la performance • 'tout tout de suite' , réponses instantanées et individuelles • recherche de sensation, besoin d'intensité • pression, stress au travail, précarité • Être cool à tout prix, refuser l'anxiété • Recherche d'anesthésie • Eviter la relation à l'autre, éviter les conflits • Auto-administration rapide des plaisirs et soulagements par divers produits...								
Comment agir ?	Prévention primaire : • Contexte sociétal • risque d'expérimentation précoce • situation psychosociale Prévention secondaire • repérage précoce et intervention brève Accompagnement vers le soin (sevrage ou réduction des risques) soignent les effets nocifs et la dépendance									

CHAP 2 : TABAC

Intro	Urgence planétaire : • 5 millions de victimes par an dans le monde : toutes les 6 sec, une personne meurt du tabac • Tue prématurément 1 de ses consommateurs sur 2 • Première cause de décès évitable • Effets nocifs n'apparaissent que plusieurs décennies après le début de la consommation Tabagisme en Fce • Age de la première cigarette vers 11 ans • 27 % des 12-85ans déclarent fumer quotidiennement • (4,7 % occasionnellement) • L'état reçoit chaque année 12 milliards d'euros de taxes issues de la vente du tabac. Le coût social est de 15 milliards Nb de décès augmente chez femme (x7 en 20ans), diminue chez homme Tue chaque année en Fce : > 73 000 personnes = Alcool + Accidents route + SIDA + suicides + homicides + drogues illicites N'épargne aucun organe → 2/3 fumeurs n'atteindront pas l'âge de la retraite
Femmes	Tabac + pilule = cocktail explosif • Augmentation du risque CV et AVC • risque de phlébite et/ou embolie pulm • Augmentation du risque de 50 % du cancer du sein • Frein à la fécondité • Risque de fausse couche x2, risque GEU x3 si 20 cigarettes/jour • Nicotine passe le lait • Donne une silhouette masculine • Lésions de la peau avec nette amélioration suite à l'arrêt du tabac
Hommes	• FdR CV supplémentaire • 80 % des hommes frappés par un infarctus avant 50 ans ont pour seul risque la conso de tabac • Vie sexuelle réduite en cendres : tb de l'érection possibles dès 25 ans chez les fumeurs, x27 risques d'impuissance, diminution libido → réversible en cas d'arrêt ! • Augmentation stérilité
Infos	- Risq CV plus élevé dès le tabagisme passif - 4000 composés → pas la nicotine qui cause les pb • CO (hypoxie), benzopyrène, polonium, cadmium, acroléine, dioxines, nitrosamines
Arrêt du tabac	- Après les 20 premières minutes (donc c'est très rapide, c'est l'espace entre 2 cigarettes) déjà la pression sanguine et les pulsations cardiaques redeviennent normales. - Au bout de 8h, l'oxygénation des cellules commence à s'améliorer. - et au bout de 24h, le risque de crise cardiaque diminue déjà. Les poumons qui se remettent à fonctionner, en particulier les cils qui bordent toutes les cellules, commencent à éliminer le mucus et les résidus de la fumée. - Et puis à 48h, (ça devient très perceptible) le goût et l'odorat s'améliorent. - Au bout de 72h, on respire mieux, on est moins essoufflé - et au bout de 2 semaines à 3 mois, la fatigue diminue puisque le corps est oxygéné et n'a plus de monoxyde de carbone, on marche plus facilement. - Au bout de quelques années, c'est là qu'on voit les risques sur la santé, au bout d'un an le risque de crise cardiaque a diminué de moitié et celui d'atteinte cérébrale rejoint celui d'un non fumeur. - Il faudra attendre 10 ou 15 ans pour que l'espérance de vie soit identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé.

Le Conseil Minimal



Dépendance à la nicotine

- Sd de Sevrage : pulsions, tb de la concentration, augmentation de l'appétit, insomnies, irritabilité, agressivité, anxiété, humeur dépressive
- Drogue la plus addictives

PeC :

- substituts nicotiniques : patch, gommes, pastilles, inhalateur, spray
- Varénicline
- Thérapies cognitives et comportementales

Motivations : accompagner !!

La technique la plus efficace : nicotine en patch et en pastille + soutien comportemental

1 cigarette roulée = 1-2 cigarette

Cigarette électronique

- Pas de CO → vapeur d'eau
- Pas de carcinogènes
- Mais présence d'autres irritants (moins quand même)

Toxicité :

- aigu si ingestion du liquide (nausées, vomissements, céphalées, vertiges)
- Risque d'addiction à la nicotine
- 30 % étaient non fumeurs ou ex fumeurs
- 75 % fument encore
- toxicité cutanée



Haut Conseil de la Santé Publique 02/16

Recommandations :

- Poursuivre lutte anti tabac
- Informer sans publicité professionnels de santé et fumeurs
- Maintenir modalités d'interdiction de vente (en particulier en pharmacie) et de publicité
- interdiction utilisation dans les lieux à usage collectif
- « Données scientifiques insuffisantes pour recommander ce produit à nos patients » mais il faut accompagner ceux qui l'ont choisie.



Invitation

- À faire des études épidémiologiques et cliniques sur la e-cig
- A clarifier le statut
- A assurer le maximum d'information aux consommateurs. Quantité de nicotine, arômes artificiels souvent inconnus. Eviter les produits importés
- **A engager l'industrie pharmaceutique pour créer une e-cig « médicament »**

Convention-Cadre de l'OMS pour la Lutte AntiTabac CCLAT (2003)

■ Réduire la demande de tabac

- Augmentation du prix en majorant les taxes : la plus efficace **si hausse importante (au moins 10% du prix du paquet)**
- Protection contre la fumée passive : interdiction de fumer dans les lieux publics et espaces de travail. Ceci change aussi l'image sociale du tabac.
- Réglementation de la composition des produits du tabac
- Réglementation sur l'emballage (information des conséquences sur la santé, suppression de la mention « light »)
- Interdiction publicité (qui fait du tabac un produit « normal » et qui est efficace auprès des jeunes), promotion et parrainage
- Programmes d'éducation, communication et formation : **à suivre**
- Mesures d'aide à la prise en charge de l'arrêt du tabac : aide comportementale et/ou médicamenteuse accessible et d'un coût abordable



■ Réduire l'offre de tabac

- Lutte contre le commerce illicite (contrebande, contrefaçon)
- Interdiction « active » de la vente aux mineurs et par les mineurs
- Programmes d'aides économiques pour l'abandon de la culture du tabac et remplacement par autres activités

Education, communication, formation et sensibilisation du public

Informer sur les conséquences négatives du tabagisme et les avantages d'une vie sans tabac

Campagnes de prévention grand public : rendre le tabac moins attractif socialement. Journée Mondiale Sans Tabac, tous les 31 mai, instaurée par l'OMS.

Intervention sur le terrain : projets spécifiques auprès de publics prioritaires (jeunes et populations vulnérables)

- intervention dans les milieux de vie, avec les personnels qui travaillent dans ces milieux spécifiques
- messages adaptés aux caractéristiques et aux besoins

Formation de professionnels-relais des secteurs social, médical, de l'enfance et de la jeunesse

Politiques anti-tabac en France

■ Prévention structurelle

- Interdiction vente aux mineurs
- Interdiction fumer dans les lieux publics
- Interdiction de promouvoir le tabagisme
- Suppression appellation « light », « légères » ou « mild »
- **Paquets neutres et avertissements sanitaires « choc »**
- **Augmentation du tarif de vente des produits du tabac**

■ Prévention comportementale

- Forfait/remboursement SN
- Consultations de tabacologie
- Assistance téléphonique (3989), application mobile site internet Tabac Info Service
- « Moi(s) sans tabac »,
- Journée mondiale sans tabac le 31 mai
- **Education à la santé dans collèges et Lycée**

Prix : Diminution avec l'augmentation du prix

Novembre : mois sans tabac en Fce avec kit, appli et 39 89

Une lueur d'espoir : passage de 29 à 27 % de fumeurs quotidiens en Fc, 1 millions de fumeurs en moins en 2017, 66 % des fumeurs déclarent avoir envie d'arrêter

Impact sur l'env : déforestation, pesticides, appauvrissement pays producteurs, pollution et incendies

CHAP 3 : ALCOOL

Epidemio	En pop G : Baromètres Santé → A l'âge de 17 ans (études ESCAPAD) : recul net de l'expérimentation et l'usage régulier 5 (++ H), les alcoolisations ponctuelles importantes (>5 verres en une occasion) au cours du mois concernent 44 % des jeunes → Au collège (étude Blitz – Isère) => passage de 26 L à 11,7L depuis 1961 - Usage Homme > Femme	
Devenir de l'alcool	Absorption	• par la muqueuse buccale et l'oesophage (--) • par l'estomac (20%) • par l'intestin grêle (80%) => diffusion passive
	Passage dans le sang	Foie : usine de transformation • voie principale (ADH et ALDH) : alcool → acétaldéhyde → acétyl coA + CO2 • Voie du MEOS (microsomes) • Voie accessoire (catalase) => 1g d'alcool = 7 kcal stockés uniquement (non utilisables)
	Elimination	• Non transformé (5-10%) ◦ air (poumons) ◦ sueur (peau) ◦ urines (rein) • Lait maternel 10 % • Transformation 90 % par le foie Elimination lente : 0,10 à 0,15g/L/heure
	Alcoolémie max : • En 45min à jeun • En 90min au cours d'un repas /!\ ça dépend de l'âge, sexe, boisson gazeuse (plus rapide), ajout de sucre... Inégalité H/F : • Pour une même qté, l'alcoolémie F>H à poids égal aussi et élimination plus lente Alcool – Boissons énergisantes • moins de maux de tête, moins de fatigue, moins souvent bouche sèche, moins a perception des trouble de la coordination • Comportements à risque : sport, défis, sexe, accidents de la route	
Effets sur l'organisme	• Atteintes des mb des cellules ◦ déformation ◦ rigidité ◦ éclatement, remaniement • Tous les organes sont touchés	
	Effet à court terme	• Effets directs de l'éthanol : l'ivresse • Trois phases successives : ◦ Phase d'euphorie et d'excitation ◦ Phase plus calme, avec perte de coordination motrice, pupilles dilatées, nausées ou vomissements ◦ Phase léthargique, sommeil → coma <u>Alcoolisation massive (API) :</u> - Risques nbeux pour la santé : sexe à risque, lésions cérébrales, apparition dépendance alcoolique - Conséquences sociales : violence, absentéisme et baisser perf scolaires et/ou pro, risque accru accidents de la route

		→ atteinte de la matière grise et blanche : atteinte globale avec des répercussions sur l'apprentissage, mémorisation et fct exécutives
		1/3 accidents de la route
	Long terme	Dépendance Cirrhoe hépatique, cancer du foie & VAS & estomac & côlon & vessie & poumon Pancréatite aigüe, HTA, Diabète, Polynévrite
Prévention	1 verre = 1 unité d'alcool = 10g pur Recommandations Fc • Pas plus de 2 unités d'alcool par jour • <10 unités par semaine (5 jours de conso et 2 jours d'abstinence) • Pour un risque « acceptable » de 1 décès pour 100 attribuable à l'alcool Prévention primaire : • Réduire les conso (qté, fréquence) % ivresse aigüe • Eviter l'entrée dans la dépendance et la survenue des complications somatiques et psychiq • Cadre réglementaire et législatif • Campagnes de prévention gd public • Education sanitaire • Centres d'aide (CJC et CSAPA) Ivresse publique interdite → amende ou chambre de sûreté <u>Loi Evin 1991</u> : interdit pub d'alcool dans la presse jeunesse et diffusion à la radio (mercredi, et 17h-minuit), la distribution aux mineurs de docs vantant les mérites d'un alcool, la vente d'alcool dans les établissements d'act physiques et sportives <u>Code de la route</u> : 1ère cause de mortalité (1/3) <0,5g/L sinon amende <u>/!\ jeunes conducteurs</u> : 0,2g/L → 0 verres <u>Taxes</u> : plus l'alcool est fort, plus il est taxé → 20 % prix du vin, 60 % bouteille de whiskey + impôts indirects & cotisation SS Campagnes de prévention (Santé Publique Fc) Education sanitaire auprès desjeunes (compétences psychosociales) Consulta° jeunes consommateurs (toutes les addictions : alcool, cannabis, jeux vidéos, internet) CSAPA ambulatoire : Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie	

CHAP 5 : MEDICAMENTS

De l'usage à la dépendance	Quelques définitions : - l'<u>usage simple</u> se définit par une consommation sans complications, ponctuelle par curiosité ou par entraînement, occasionnelle en petite quantité - le <u>mésusage</u> est une utilisation intentionnelle non conforme d'un médicament - l'<u>abus</u> est une consommation intentionnelle et excessive d'un ou plusieurs produits avec des conséquences préjudiciable à la santé - la <u>pharmacodépendance</u> (terme privilégié par l'OMS mais également appelée toxicomanie) est une relation aliénante à une substance psychoactive, dont l'absence de consommation entraîne une souffrance psychique, voire physique, caractérisée par un état de manque. Elle se caractérise donc par le désir obsessionnel hautement prioritaire de se procurer cette substance et d'en consommer de manière compulsive (ce qu'on appelle le craving), quelles que soient les conséquences pour sa santé. <u>La dépendance psychique</u> est le plus puissant des facteurs de dépendance, deux mécanismes entrent en jeu : • soit le médicament induit un état de satisfaction dû au plaisir : c'est ce que l'on appelle un renforcement positif • soit il soulage un mal être : c'est alors un renforcement négatif <u>La dépendance psychique</u> - certains médicaments, - organisme s'adapte à une consommation prolongée. - augmentation des doses pour retrouver l'effet initial conduisant au risque d'overdose (potentiellement létal). - La privation du médicament entraîne un syndrome de sevrage avec des symptômes spécifiques à chaque produit. Dépendance médicamenteuse : - Méconnue : dérive d'une prescription médicale = escalade médicamenteuse - Avérée : dépendance 2ndaire, nombreuses classes - Toxicomane : Ttt de Substitution aux Opiacés (TSO), licites OU de trafic, illicite (transgression : détournement d'ordonnances) => enquête OSIAP : demandeurs des ordonnances falsifiées ++ hommes, dans 16 % des cas - patient connu => +++ Zolpidem Comportements de transgression : • Finalités : récréatives, lucratives, délictuelles, criminelles • Soumission chimique !
Psychotropes	• Plusieurs catégories : - Anxiolytiques et hypnotiques (benzodiazépines et apparentés +) - Antidépresseurs - Antipsychotiques - Régulateurs de l'humeur (lithium notamment) - Psychostimulants (méthylphénidate et modafinil) • Dans la majorité des cas, la prise de ces médicaments ne relève pas de pratiques toxicomaniaques, mais thérapeutiques • Du fait des perturbations de la vigilance et des dépendances que certains entraînent, ces médicaments peuvent donner lieu à des usages problématiques ou à risques Des produits licites • Les médicaments psychotropes sont obtenus sur prescription même s'ils n'ont pas toujours été prescrits au consommateur lui-même • L'obtention par ordonnance falsifiée semble marginale - 11 benzodiazépines ou apparentés figurent dans le top 20 des tentatives de falsification d'ordonnance • Si le marché parallèle de médicaments peut être bien visible dans certaines zones des grandes villes, aucun trafic organisé de médicaments psychotropes non opiacés n'a été repéré • Aucune information sur le poids du commerce de médicaments sur Internet France : un des pays les plus consommateurs

Epidémiologie

- **Peu de données** quantitatives sur l'**addiction** aux médicaments psychotropes
 - Où se situe la frontière entre usage et mésusage ?
- Un niveau de consommation de benzodiazépines **élevé** en France :
 - 2^{ème} rang de la consommation de benzodiazépines en Europe derrière l'Espagne en 2015
 - 13,4 % de la population française a consommé au moins une benzodiazépine
- La France ne se démarque pas s'agissant des antipsychotiques
- L'utilisation des psychostimulants reste inférieure à celle de nos voisins européens

En population adolescente

- En 2015, parmi les lycéens : **11 %** déclarent avoir déjà pris des tranquillisants ou des somnifères, les ♀ + souvent que les ♂
- Chez les jeunes de 17 ans, **16 %** ont déjà pris au cours de leur vie des anxiolytiques, **13 %** des hypnotiques et **6 %** des antidépresseurs
- A 16 ans, **7 %** des jeunes Français ont expérimenté la prise concomitante de médicaments et d'alcool « pour planer ou se défoncer »
- Les médicaments consommés n'ont pas toujours été prescrits à l'utilisateur : chez les 17 ans, la prise de médicaments psychotropes ne se fait à l'initiative d'un médecin que dans **la moitié** des cas environ, dans **27 %** c'est l'un des parents qui propose le médicament, et **11 %** l'ont pris de leur propre initiative
 - = **banalisation** des psychotropes chez les adolescents !

Accidents de la route

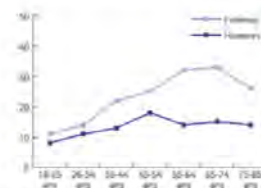
Arrêté du 15 mars 2017 modifiant l'arrêté du 9 août 2009 pris pour l'application de l'article 6, §2 du code de la route de la carte nationale de permis à l'égard des personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire



- En France, **3,4 %** des accidents de circulation mortels sont liés à une prise de médicament
- Les benzodiazépines sont responsables de **la moitié** des accidents mortels liés aux médicaments

Un enjeu de santé publique !

- En 2010, **16 %** des **18-75 ans** déclarent avoir pris au moins un médicament psychotrope au cours des 12 derniers mois
- En 2016, les ventes sont en légère ↓, mais **3,5 boîtes** de psychotropes sont remboursés par habitant âgé de 20 ans ou +



Risques liés à la consommation

1. Chez l'ensemble des consommateurs : troubles de la **mémoire** et du **comportement**, **baisse de la vigilance**, facilitant la survenue d'accidents
 - Principalement pour les **benzodiazépines**
 - Risques + importants en **début de traitement**, lors de **prises occasionnelles**, en association avec l'alcool ou d'autres psychotropes
2. Des risques propres à **chaque individu** (en cas d'antécédents médicaux particuliers, de variations du métabolisme hépatique, de traitement au long cours, etc.)
3. Des **mésusages** de médicaments : abus, **dépendance** ou l'usage pour un autre effet que thérapeutique (**usage « récréatif »**), **dopage** pour les psychostimulants, **soumission chimique**, etc.)

Les usages non conformes

- Des **durées de prescription** non respectées
 - Anxiolytiques maximum 12 semaines, hypnotiques 4 semaines
 - Pourtant la durée médiane de traitement par une benzodiazépine est de **7 mois** !
- Consommation chez les usagers de drogues
 - Principalement les benzodiazépines
 - Rarement voie d'entrée dans la toxicomanie
 - **29 %** des usagers actifs déclarent en avoir pris au cours du dernier mois
 - Des pratiques d'injection sont parfois décrites
- Risque d'usage criminel
 - Benzodiazépines et **soumission chimique**

Opiacés

- Une famille de produits obtenus à partir de l'**opium**, produit **sédatif** d'origine naturelle, provenant de cultures de pavot :
 - **alcaloïdes naturels (opiacés)** : morphine, codéine, papavérine, noscapine, buprénorphine
 - **semi-synthétiques ou synthétiques (opioïdes)** : héroïne, hydromorphone, hydrocodone, oxycodone, oxycodone, méthadone, dihydrocodéine, tramadol, fentanyl
- Prescrits comme **antalgiques** ou **antitussifs**, **TSO** ou comme **anesthésiques**

Antalgiques opiacés

- Douleurs **modérées à sévères**
- Capacité ++ à induire une **dépendance psychique et physique**
- Antalgiques de palier II (opioïdes faibles) : codéine, dihydrocodéine, tramadol, opium
 - Possible détournement d'usage
 - Risque de dépendance majoré en cas d'**usage prolongé à dose élevée**
 - Possible dépendance **physique**, surtout avec la codéine et le tramadol
- Antalgiques de palier III (opioïdes forts) : morphine, fentanyl, oxycodone, hydromorphone
 - Lorsque les antalgiques - puissants sont insuffisants
 - Dans les douleurs non cancéreuses : utilisation la + **courte** possible !
 - Possible dépendance **psychique** et **physique rapide**

Intoxication par opiacés ou opioïdes

1. **Coma** (calme, hypotonique, avec myorelaxation)
 2. **Bradypnée** (fréquence respiratoire ≤ 12/min)
 3. **Myosis** (bilatéral, serré, en tête d'épingle)
- Tous les morphiniques induisent une dépression respiratoire faisant courir le risque d'apnée centrale et de **décès**
 - L'association fréquente de **psychotropes**, tels que les benzodiazépines ou l'**alcool**, ↑ l'intensité de la dépression respiratoire
 - La consommation par voie injectable expose à des **abcès** et à des risques de **contamination** (VIH, VHC, VHB)

Epidémiologie

- En 2017 : **1,1 %** des Français ont consommé au moins une fois un antalgique de palier III, contre 0,54 % en 2004
- ↑ des hospitalisations pour surdosage d'antalgiques de **167 %** entre 2004 et 2017
- ↑ de **172 %** du nombre de décès par opioïdes depuis 2000
- Les prescriptions pour des douleurs non cancéreuses ont ↑ de **88 %** depuis 2004
- Palier II : **84,2 millions** de boîtes vendues en 2017, contre **58,1** en 2008
- Palier III : **12 millions** en 2017, contre **10** en 2008

Antitussifs opiacés

- « Purple drank » = boisson à base de sirops antitussifs (prométhazine, **codéine**) et de soda
- 1^{ers} signalements rapportés en France en **2013**
- Potentiel d'abus et de dépendance :
 - **Adolescents** (♂ et ♀), jeunes adultes
- Risques : troubles de la vigilance (sommolence), du comportement (agitation, confusion, délire), convulsions, **décès**
- En 2017 : **8,5 %** des jeunes de 17 ans déclaraient avoir déjà consommé



En résumé

- Parmi les médicaments psychotropes, les **anxiolytiques** et **hypnotiques** présentent un **potentiel addictif reconnu**
- Hypnotiques : PAS de prise **régulière** sur une **longue** période
- Anxiolytiques : **dose minimale efficace** pour limiter le risque de dépendance
- Le sevrage des psychotropes peut nécessiter une **hospitalisation**, il est toujours très progressif, sur plusieurs semaines et guidé par les symptômes
- **DANGER** en cas de prise concomitante **d'alcool**
- **DANGER** vis-à-vis de la **conduite**

- Les **antalgiques** ou **antitussifs opiacés** présentent un **risque majeur d'abus** ou de **dépendance**
- Antalgiques opiacés : **réévaluation régulière** et **arrêt progressif**
- Les antitussifs opiacés ne sont **plus disponibles** en vente libre depuis juillet 2017
- La dépendance aux opiacés peut nécessiter la mise en œuvre d'un **TSO**, des mesures d'accompagnement psychologique et de soutien à long terme pour prévenir une rechute
- L'intoxication ou « overdose » aux opiacés fait courir un risque de **décès**

- **D'autres médicaments** peuvent faire l'objet d'abus et/ou de dépendance : antihistaminiques sédatifs, antiparkinsoniens, antimigraineux, laxatifs et diurétiques (troubles du comportement alimentaire), corticoïdes et bronchodilatateurs (dopage), vasoconstricteurs, etc.
- Les **signes d'alerte** : ↑ des doses, nomadisme médical ou pharmaceutique, demande insistante pour un médicament et refus d'une alternative, prise du traitement des proches ou automédication...
- Les médicaments **en vente libre** ne sont PAS sans danger !

CHAP 4 : SUBSTANCES ILLICITES

Intro	- <u>Drogue</u> = toute substance qui modifie la manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions, de penser et de se comporter - Classification des drogues : légale/illégale, dangereuse ou non, en <u>fonction des effets</u> : → Neuroleptiques (antipsychotiques) : • Stimulants : ◦ dépendance psychique forte ◦ accrochage très rapide ◦ accident de surdosage gravissimes et responsables de dc malgré PeC précoce ◦ risques de tb comportementaux ou vascu graves • Dépresseurs (ralentit fonctions) ◦ forte dépendance physique et psychique ◦ accrochage lent à rapide (héroïne) ◦ En cas de surdosage : coma ◦ A long terme : tb neurocomportementaux • Hallucinogènes ◦ dépendance psychique faible à modérée ◦ risques de décompensation psychotique <u>Usage sans risque ?</u> • Aucune conso de drogue n'est sans risque ! • Même et peut-être surtout lorsqu'il s'agit d'une 1ère fois • Installation d'une addiction : ind x env <u>Loi :</u> • >200 substances psychoactives interdites • = Liste française des stupéfiants • En fonction de toxicité, intérêt thérapeutique, potentiel d'abus et de dépendance (ANSM) • Interdiction de faire usage, de produire, d'importer ou exporter, transporter, posséder, proposer, vendre • Obj : protéger la santé publique <u>Protection des mineurs :</u> • Des règles spé : lorsque les mineurs sont visés + dans ou à proximité d'un établissement scolaire • L'école, lieu de règle : règlement intérieur rappelle l'interdiction + sanctions disciplinaires et signalement au Procureur de la République • Lieu de prévention et d'aide : rencontrer le personnel de santé de l'établissement + CJC Epidémio : • Cannabis : la drogue illicite la plus consommée en Fce
Nouveaux produits de synthèse	Très hétérogènes → « imitent » les effets d'autres substances (ecstasy, cannabis...) Structures proches mais pas identiques Certains classés stupéfiants, d'autres n'ont pas de statut juridique clair Internet +++ : 8-20€/g sur internet, 3x > dans la rue Associé à des pratiques « Slam » « Chemsex » 3,8 % 17ans en ont consommés (11,8 % → cannabinoïdes) En Fce : • Cannabinoïdes de synthèse ou « Spice », proche du THC • Phénéthylamines, proches MDMA ou LSD • Méthoxétamine (MTX) Dosages et effets variables +++

Licites mais pas sans risque	Poppers : Nitrite → inhalation : euphorie, rire, vasodilatation, contexte sexuel ++ • Prise unique : risque nausées, vomissements, céphalées • Prise répétée : lésion nasale et du visage, atteintes hépatiques • Intoxication : hypotension artérielle et tb CV (mortels), anémie aiguë et grave, perte prolongée de l'acuité visuelle • 17ans → 8,8 % Protoxyde d'azote : euphorie, risques brûlures par le froid, asphyxie, risque fausse route • Usage régulier : pertes de mémoire, tb humeur, hallucinations visuelles, tb rythme
Hallucinogènes	• Les principales naturelles consommées sont contenues dans des champignons « hallucinogènes » qui peuvent pousser en France (psilocybe++) ou être exotiques(mexicain, hawaïen, colombien) • Les plantes hallucinogènes ou préparations à bases de plantes comme ◦ la sauge divinatoire (+ consommé après les champs). ◦ Le datura stamonium, l'iboga ou la rose des bois :- diffusé • De synthèse les + connus, bcp – consommé sont : ◦ LSD (acide lysergique produit par un champi : l'ergot de seigle qu'on trouve le + svu sous forme liquide ou déjà sur un buvard destiné à être avalé) ▪ il entraîne des modifs sensorielles intense provoque des hallux et une perte +/- marquée du sens des réalité, l'usager peut éprouver des angoisses, crises de panique ou bouffées délirantes ; la descente peut être très désagréable et générer un profond mal être. ◦ la kétamine : utilisée comme anesthésiant vétérinaire et humain entraîne à dose modérée des effets euphorisants et une ébriété «cotonneuse», à dose + forte elle entraîne des hallux mais aussi des effets dissociatifs essentiellement de rupture de l'unité psychique et corporelle. ▪ On la trouve sous forme liquide ou cuisinée sous forme de poudre. ▪ La conso provoque un engourdissement avec perte du sens de l'espace un sentiment de dissociation entre le corps et l'esprit elle peut être à l'origine de perte de connaissance voire de coma ◦ le GHB/GBL (précurseur : solvant industriel transformé en GHB par l'organisme) : substance anesthésique d'abord euphorisante puis sédative et amnésiante que le GHB sur la liste des stupéfiants mais le GBL est interdit à la vente et à la cession au public depuis 2001 en raison des risques de soumission chimique les hallucinogènes provoquent des distorsions des perceptions visuelles, auditives, spatiale, temporelles et de la perception de son corps ▪ Complications aiguës : « bad trip », épisode délirant, malaises à tonalité cauchemardesque,angoisses, effet parfois durable (pls j : usagé scotché ou perché), trauma graves, risque d'accident mortels (défenestration, noyade), coma (parfois recherché par les usagers) en 2017, 1.6% des jeunes de 17 ans déclarent avoir consommé du LSD au cours de leur vie

HAMAC = hypnotique, anticonvulsif, myorelaxant, anxiolytique,

cannabis = 3 possibilités

héroïne = sédatif

amphet = stimulants, hallucinogènes

adultes : medocs psychotropes

retour d'acide : LSD, effet à distance

	Cannabis	Cocaïne	MDMA (ecsta) / amphét(speed)	Héroïne
Origine	Cannabis sativa (chanvre indien) 3 formes : - herbe - résine (haschisch) - huile (+concentré)	Subst végétale → feuille de coca : Crack = bicarbonate ou ammoniac > cristallisation → à fumer (+ puissant)	Synthèse	Opioïde
Effet	Dus au THC	Stimulant	MDMA : hallucinogène Amphèt : psychostimulant + puissant	Equivaut morphine mais plus rapide, plus intense, plus brève
Mode de conso	Collectif	Voie nasale, inhalation, IV	MDMA : avalée, sniff Amphèt : sniff, – injectée	IV, sniffée, fumée « chasser le dragon »
Teneur	Résine : 23 % THC (à augmenté) Herbe : 10 % THC	Augmenta° pureté : 65 % Produit de coupe : lévamisole (80%) → vermifuge véto	MDMA : - Cristal : 73 % - Ecstasy : 128mg Amphet : - 40 %	14-16 %
Prix	11€/g herbe, 7€/g résine	80-85€/g	MDMA : 54€/g cristal, 2,5 à 10€/cp Ecstasy : 15€/g	35-40€/g
Ados	Collégiens : 1ère substance illicite consommée par les ados → à partir de la 4ème : 1/4 à 17 ans ont déjà fumé (++ H)	17ans : 2,8%	17ans : - MDMA : 3,4 % - Amphet : 2,3 %	Régionales : Lyon, Annemasse, Annecy 0,7 % des 17ans
Risques	- 15-20min = effets - Prise unique : euphorie puis somnolence, (-) mémoire et tb de l'attention, tb coordination motrice, symptômes psy (hallucinations, tb anxieux) - Prise régulière : diminution apprentissage, désintérêt, fatigue, dépression Risque de dépendance Risque Kc poumon	- indifférence à la fatigue - « phase de descente » : dépression, anxiété, irritabilité - Complications : cardiaq, neuro, lésion nasale, infections virales, tb délirants - Dépendance psychique ++	- Dissipent faim et fatigue, euphorie, hyperconcentra°, contacts - Descente : dépression, anxiété, tb sommeil - Complications : tb neuropsychy, hypertonie, hyperthermie, tb CV, mortel	Dépendance +++ et « overdose » svt mortelle

MODULE 4

CHAP 1 : SANTE MENTALE ? PREVENTION DU SUICIDE

Epidémio	9000 personnes meurent chaque année par suicide en France (2 % décès) – dont 400 jeunes de moins de 24 ans - Hommes meurent 3x plus que les femmes - Femmes réalisent plus de tentatives de suicides - Tentatives de suicide sont nombreuses chez les jeunes avec parfois des séquelles graves
FdR	- Mal être, isolement - Evénements de vie difficiles (harcèlement, maltraitance, rejet, deuil, ruptures...) - Avoir déjà fait une tentative - dépression : 1/5 personnes ont souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie - Facteur de risque de suicide important : 5 à 20 % des patients se suicident - traitements efficaces dans 70 % des cas 8 % des jeunes entre 12 et 18 ans souffriraient de dépression - VRAIE maladie - Signes : tristesse, perte d'intérêt, ralentissement, irritabilité, dévalorisation, culpabilité... - Conséquences : repli, stress, absentéisme scolaire, conduites à risques, addictions... Le suicide n'est pas un choix : c'est la dernière solution qui s'impose pour arrêter de souffrir
Repérer	- Signes internalisés - repli et isolement, tristesse, perte d'envie et de plaisir - Signes externalisés : - comportements impulsifs (colère, violences, fugues) - prises de danger (conduites, drogues, alcool, automutilations, anorexie) - Signes verbaux - des paroles évoquant le mal être doivent alerter : « j'en peux plus... » - des envies de mourir, des idées suicidaires : « j'ai plus qu'à me foutre en l'air... », doivent toujours être prises au sérieux et faire réagir La majorité des personnes qui se suicident en avait parlé avant ! Un demandeur d'aide = un appel au secours
Aider	Faire le premier pas : - oser aller vers la personne qui souffre pour rompre l'isolement - se sentir légitime pour aider qq'un qui va mal - ne pas attendre que qqun d'autres réagisse même si on ne se sent pas à la hauteur - ne pas cautionner le rejet ou le harcèlement d'un gpe - il suffit d'un regard, sourire, petit mot, texte pour amorcer cette aide - trouver le bon moment pour faire le premier pas et parfois le faire à deux Lui parler : - être attentif et bienveillant sans juger et sans vouloir trouver les solutions trop vite - éviter de parler de soi ou de comparer - reconnaître qu'il puisse aller mal et lui dire que l'on voit qu'il est en difficulté - respecter sa confiance mais en lui disant parfois qu'il est nécessaire d'en parler à un adulte (s'il évoque des idées suicidaires) « ce que tu me dis est trop grave pour que je le garde pour moi » /!\ pas derrière son dos - Oser lui demander s'il a des idées suicidaires L'aider à se faire aider : - le rassurer : « on ne peut pas toujours se débrouiller seul » - les adultes de confiance seront rassurés de le voir demander de l'aide - parler de son pb, c'est pour agir et tenter de trouver des solutions - aider à trouver un adulte en qui il a confiance et qui pourrait l'aider - un adulte de la famille, de l'établissement, club, parent d'un ami, pro ? - Ne pas lâcher, ne pas penser que tout est réglé, rester au contact : - pour l'accompagner, l'aider à appeler, prendre des nouvelles, s'assurer qu'il a pu en parler

COORDONNÉES RESSOURCES

- Dans l'établissement scolaire:
Nom de l'infirmière scolaire; médecin scolaire; assistant social...
- Médecin généraliste
- Maison des adolescents: <https://www.ado38.fr/Grenoble.html>
GRENOBLE, 74 rue des Allies 04 56 58 82 00
VIENNE, 4 rue Emile Romanet 04 74 53 89 21
BOURGOIN JALLIEU, 18 rue Joseph Cugnot 04 37 03 43 74
- Allo écoute Ados: 0 800 506 692 Appel gratuit depuis un poste fixe
- Fil santé jeune: 0 800 235 236
- Urgence
Possibilité de se rendre aux urgences à toutes heures en cas de danger pour rencontrer un professionnel de santé
- SAMU centre 15: Si les idées suicidaires sont trop envahissantes, et si le risque de passage à l'acte est imminent.



TOUT LE MONDE peut un jour se sentir triste, malheureux, déprimé, sans énergie, seul et en souffrir.

STOPBLUES

une application et un site web pour

- connaître les signes du mal-être
- en comprendre les causes
- trouver des solutions...

... POUR VOUS ET VOS PROCHES

www.stopblues.fr

Un coup de blues, déprimé-e ? Faire le point et trouver de l'aide

UNE APPLI GRATUITE POUR ALLER MIEUX

DISPONIBLE DÈS 2018

Obtenez sur **App Store** **Google Play**

Service public de France

Sous le haut patronage des Ministres en charge de la santé et de la recherche

Inserm

CHAP 2 : HARCELEMENT SCOLAIRE

Intro	• 1 enfant/10 → 1 million : 12% en primaire, 10 % au collège, 3-4 % au lycée • Garçons plus svt frappés / bousculés • Filles davantage exposées aux mauvaises rumeurs HS = violences entre élèves du même âge ou même tranche d'âge → stigmatisation Se déroule : • Dans l'établissement sco • Et/ou sur les trajets entre le domicile et l'établissement • Et jusqu'au sein du domicile pour le cyberharcèlement (favorisé par l'anonymat) Multiples actions d'agressions → polymorphe Critères : • intentionnalité de nuire, de porter préjudice • répétition des actes • longue durée des actes • dissymétrie des forces avec mise en place d'une relation dominé-dominant
Protagonistes	4 profils : • les victimes : subissent ◦ l'emprise psychique peut l'amener à croire qu'elle mérite une telle situation ◦ possible endossement de la responsabilité qui conduit à la honte ou à la culpabilité qui empêchent de parler ◦ aggravation de l'isolement relationnel • agresseurs : agressent sans subir ◦ différence perçue chez la victime renvoie le harceleur à ses propres faiblesses qui sont évacuées sur un bouc émissaire ◦ ont peu de capacités d'empathie ◦ ont svt des tb psy dits externalisés (hyperactivité, impulsivité, tb des conduites) • agresseurs / victimes : double jeu • « neutres » : élèves non concernés. N'interviennent pas car : ◦ peur de représailles ◦ sentiment que ce n'est pas leur affaire ◦ on ne cafte pas ◦ victime devrait se défendre seule Rôle primordial des témoins : • lorsqu'ils restent passif, optant pour la loi du silence : ◦ valident le procédé, harceleur se sent conforté ◦ privent la victime de soutien et d'empathie ◦ renforcent l'ostracisme et l'isolement de la victime • pour que les témoins puissent sortir de leur silence : ◦ connaître ce qu'est le harcèlement ◦ soient sûrs de trouver des relais auprès des adultes de l'établissement ou de leur entourage
Facteurs favorisants	• Fragilité psychique, env et familiale tant de la victime ou de l'agresseur • climat scolaire de l'établissement dégradé • insuffisance de repérage ou de prise en compte par l'équipe éducative • témoins n'osant pas intervenir ou révéler les faits • victimes n'osant pas se confier à leurs parents ou amis
Tb psychiatriq	• Tb anxieux : peurs, tb du sommeil, ruminations, absentéisme • tb récents du comportement : colères, fugues agressivité • état dépressif : tristesse, irritabilité, asthénie, tb concentration, culpabilité, honte, suicide • état de stress posttrauma : flash back, ruminations, cauchemars, hyperréactivité

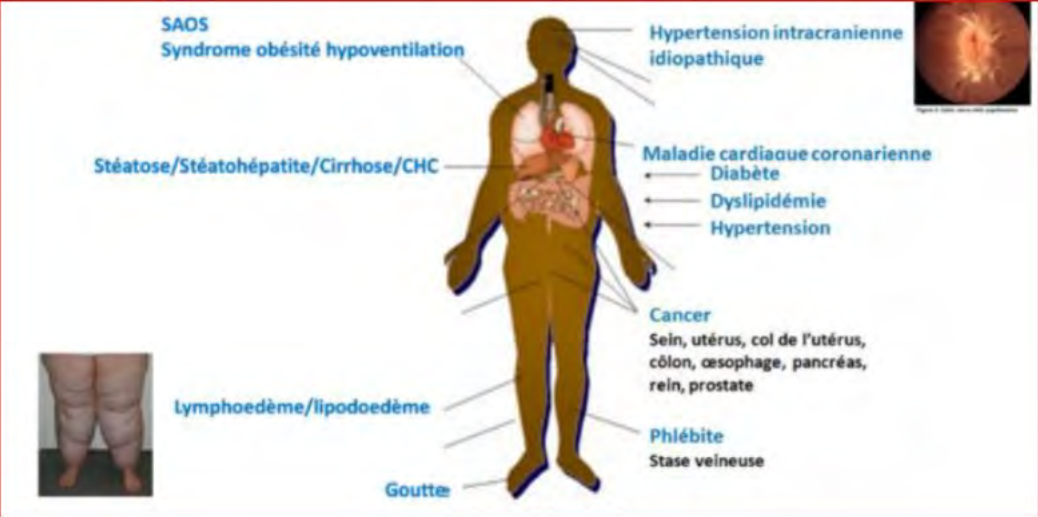
Lutte	• En faire une priorité en raison de sa fréquence et de son retentissement psychique • Connaître pour repérer et réagir : depuis 2015, il existe une journée nationale consacrée dans les écoles au harcèlement • Un bon climat sco est un facteur de protection du harcèlement • Elèves « ambassadeurs » depuis 2018 : rôle essentiel des témoins qui ne doivent pas garder le silence • Formation des chefs d'établissement, psy, infirmières sco : « référents permanents » pour les élèves « ambassadeurs » et les victimes • soutien et aide à la victimes Numéros verts : HS = 3020 gratuit / cyberharcèlement = 0800 200 200 PeC spécifiques : • dvpt confiance en soi : victime • dvpt capacités d'empathie : agresseur C'est un délit ! • 13-15 ans : 18 mois prison et 7500 euros d'amende • parents de l'auteur sont civilement responsables et devront, le cas échéant, indemniser les parents de la victime
--------------	--

CHAP 3 : LE SOMMEIL ET SON HYGIENE

Sommeil normal	• 7 à 8h avec des variations en fct âge, sexe, individu lui-même • 2 phases différentes et alternantes : ◦ sommeil lent (de léger à profond) : ▪ prédominant au début de nuit ▪ occupe une majeure partie du cycle, réduit son temps en fin de nuit ▪ « sommeil réparateur » ◦ sommeil paradoxal ▪ <=> état de veille : mvts oculaires rapides et relâchement musculaire ▪ augmente à mesure que celui du sommeil lent se réduit ▪ « rêves » • 1 cycle = 90min et sse répètent 4 à 7 fois par nuit et débute par une phase de sommeil lent
Hygiène du sommeil	• Préférable de dormir dans une chambre : aérée, en limitant les bruits et la lumière, en veillant que la température ne soit pas excessive • Heure de coucher : doit être régulière • en évitant siestes longues et tardives qui ne favorisent pas un endormissement précoce • Favoriser l'exposition à la lumière le matin et à réduire le soir => bon rythme chronobio • Act physique à limiter en fin d'après-midi et le soir • Limiter repas copieux et gras + excitants (café, tabac)
Signes d'alertes	• Difficultés d'endormissement persistantes sur plusieurs jours, semaines • Des réveils nocturnes fréquents pendant plusieurs nuits → peuvent être des signes d'anxiété, dépression → doivent motiver une consultation chez médecin traitant → ne doivent aucunement justifier une automédication par des ttt favorisant le sommeil

MODULE 5

CHAP 1 : OBESITE

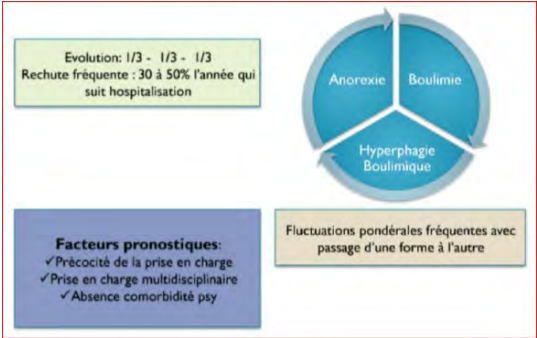
Définition	Maladie car elle affecte le bien-être physique, psychique et social de l'ind IMC : • Classe 1 : 30-34,9 • Classe 2 : 35 – 39,9 • Classe 2 : > 40 54 % chez les hommes & 44 % femmes Prévalence augmente progressivement avec l'âge, gradient socio-économique très clair /!\ ICM pas assez spé Répartition des graisses et risque cardiométabo • Périphérique / Sous-cut : ◦ métaboliquement saine ◦ qté de graisse du bas du corps 1/proportionnel : ▪ FRCV (DT2, HTA, dyslipidémie) ▪ Evenements CV ▪ Cancers ? • Centrale / viscérale ◦ corrélé à : maladies métabo, événements CV, risques de cancer Type de complications : 
Soignants	Promouvoir : • Act physique régulière • alimentation basée sur le plaisir alimentaire, la convivialité, l'attention à ce qu'on fait lorsqu'on mange • Faire émerger les propres projets de chaque personne A éviter : • conseils nutritionnels ou d'act physique directifs • culpabilisation • conseils favorisant une restriction cognitive (aliments interdits, pas d'alimentation entre les repas, petit dej obligatoire...)

Troubles Comportementaux Alimentaires	<u>TCA prandiaux :</u> - hyperphagie prandiale : prise alimentaire au repas dépassant la satiété (patient coupé de ses sensations alimentaires, convivialité, éducation) - tachyphagie : manger trop rapidement en mastiquant peu - restriction cognitive : tendance à limiter consciemment la prise alimentaire pour perdre du poids ou éviter d'en prendre <u>TCA extra-prandiaux :</u> - grignotages : conso répétitive, sans faim, sans envie, de petites qtés d'aliments facilement accessibles - compulsions : conso soudaine, rapide et en grande quantité d'un aliment donné sans lien avec la faim, s'orientant vers un aliment apprécié. Plaisir initial puis éventuellement culpabilité. - Noctophagie <u>Désinhibition</u> : prises alimentaires incontrôlées dans un contexte de restriction et de privation chroniques <u>Impulsivité alimentaire primaire</u> : prises alimentaires incontrôlées dans un contexte variable, mais svnt émotionnel (+ ou -) Crise boulimique : - conso d'une gde quantité de nourriture à l'intérieur d'une courte période de temps (<2h) - sentiment de perte de contrôle pendant la crise - sans plaisir alimentaire La boulimie : 1 crise boulimique / semaine pendant 3 mois + conduites compensatoires (purge, vomissement, comprimé) Hyperphagie boulimique : 1 crise boulimique / semaine pendant 3 mois sans CC = la plus fréquente des TCA répertoriés chez l'obèse Obésité : souvent prédisposition
Stigmatisation	Embonpoint = mal en point Préjugés culturels Imprégnation inconsciente qui peut cohabiter avec la bienveillance Discrimination = d'inconscient à conscient → culpabilité/honte → disqualification → dévalorisation intériorisée → éloignement des facultés d'adaptation /!\ grossophobie médicale - faire propre analyse des projections que vous pourriez avoir sur les personnes obèses - se questionner sur son propre rapport à l'alimentation : spontané, intuitif ? Restriction cognitive ? Préoccupatio importante autour du poids ? TCA ? - promouvoir une alimentation équilibrée, non restrictive, de l'act physique - sans culpabilisation ou emphase démesurée sur les risques associés à l'obésité car cela induit un risque d'aggravation de la stigmatisation des personnes obèses

CHAP 2 : TB COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Définition	Se définit par des conséquences bio : • IMC <17,5 = anorexie mentale, dénutrition • IMC >25 = surpoids → concerne plus les accès hyperphagiques • IMC N = boulimie nerveuse (hyperphagie avec contrôle du poids) Le plus svT associé : • à des tb psychologiques/psychiatriques • à des pb relationnels familiaux et/ou sociaux importants => boucle de rétroaction
Epidémio	Prévalence ensembles des TCA : • 2,5 % pop G • Prévalence des formes graves d'AM : 1 % des ado (30 000 en Fce) et semble en augmentation Prévalence anorexie : • 0,9 % à 1,5 % chez femmes ◦ 1,5 % entre 15 et 35 ans ◦ 0,2 à 0,3 % chez hommes en pop G • sex-ratio : 1:9 Prévalence boulimie • Prévalence ie entière autour de 1-1,5 % • 3-4 % des femmes, entre 15-45 ans • Formes partielles : x2-3 • sex ratio : 1:3 Prévalence Accès hyperphagiques • prévalence : 3 % femme • 2,5 à 3 % homme • 2-3 fois plus fréquent que la boulimie
Etiopathogénie des TCA	« polyfactorielle » - Facteurs de vulnérabilité : « terrain » génétique et/ou anomalies bio préexistantes - Facteurs déclenchants : régimes alimentaires stricts, events de vie majeurs, puberté et oestrogènes - Facteurs d'entretien : déseq bio induits par la dénutrition → mécanismes de défense • se jeter sur la nourriture (perte de contrôle) • se figer dans les restrictions
Influence socioculturelle	Promouvoir une distorsion de l'image du corps et de la bonne alimentation Modeling : imiter les comportements que l'on observe Renforcement social : internalisation des attitudes et des comportements approuvés par autrui => conséquences chez ados : • internalisation des idéaux culturels de beauté et de minceur • vulnérabilité interpersonnelle ◦ tb image de soi et du fonctionnement social ◦ sentiment d'inefficacité et insatisfaction corporelle • écart entre forme corporelle actuelle et idéal de minceur ◦ restriction alimentaires et ses conséquences

	Image du corps filles : • Veulent être minces ◦ 8ans : 23 % ◦ entre 8 et 10ans : 55 % sont insatisfaites, 46 % veulent maigrir (3 % garçons) ◦ 13 ans : 54 % (<10 % chez garçons) • 46 % filles se trouvent trop grosses alors que 12 % sont en surpoids
Anorexie mentale	Anorexie : lutte contre la faim • restriction alimentaire volontaire • sélections des aliments qual et/ou quant Amaigrissement : • perte de plus de 25 % du poids initial • IMC <17,5 • déni de la maigreur Aménorrhée primaire ou secondaire Restrictions quantitatives : • diminution des portions • saut de repas • dissimulation ou stockage de nourriture Restrictions qualitatives : sélectivité • exclusion d'une catégorie d'aliment (féculent, lipide) • végétariannisme • préférence pour les produits allégés Autres stratégies : • vomissements • coupes faim, diurétiques => pensées obsédantes, isolement social progressif, altération de la vie familiale-sociale
Boulimie nerveuse	• Crise de boulimie • Stratégie de contrôle du poids donc Poids Normal En commun avec AM : idéal minceur, insatisfaction corporelle, faible estime de soi, Restriction par contre moins sévère avec ou non conduite de purge Crise de boulimie : • épisode de surconso alimentaire, brutal, impulsif et incontrôlable • > repas copieux (1500 à 4000 kcal) • En général en cachette en temps limité (<2h) • notion de plaisir absente mais remplissage • suspend ou occulte les pensées et affects pénibles, effet « dissociatif »
Tb Accès Hyperphagique	• Crises de boulimie • Pas de stratégie de contrôle du poids donc Suproids voir obésité En commun avec autres : idéal minceur, insatisfaction corporelle, faible estime de soi, culpabilité, restriction cognitive, aliments tabous 25-50 % des sujets obèses qui se présente en ttt ont des accès boulimiques Sujets obèses avec accès boulimiques : • se disent plus préoccupés par la nourriture • se sentent moins aptes à contrôler leur alimentation • sont plus insatisfaits de leur poids et de leur apparence physique

Evolution et pronostic	
PeC multidisciplinaire	- Vigilance sur le plan somatique (poids, pds, tb métabo) → médecin G ou pédiatre - PeC psychiatrique / psychologique pour les aider à travailler sur la faible estime de soi, insatisfaction corporelle, tb anxieux, dépressifs - suivi par une diététicienne comportementaliste ou médecin nutritionniste mais spécialisé dans TCA Prévention I : • approche socio-culturelle : le corps idéal ◦ lutte contre les représentations idéalisées du corps (mannequins et top modèles) • éducation à la santé ◦ développer compétences psychosociales (estime de soi) Prévention II : dépistage • repérage précoce => PeC précoce ◦ par les proches ◦ par les professionnels : médecin traitant, médecine scolaire • pop à risque ◦ ados, jeunes femmes, mannequins, danseurs • signes d'appel ◦ modifications alimentaires ◦ amaigrissement et plaintes corporelles

CHAP 3 : ECRANS

Cyberharcèlement	Les caractéristiques du harcèlement en milieu sco : • violence • répétitivité • isolement de la victimes => verbal, physique, psychologique Il n'existe pas de déterminisme CH : • anonymat, pas de contrôle d'identité des auteurs • aucun moment de répit pour la victime • diffusion massive et instantanée • 1 élève sur 5 victime
Temps d'écrans	Nécessaire d'un temps limité ,régulé dans la journée Pas laisser l'enfant suel, passif → filtre adulte >12 ans = réseau social >9ans = internet seul >6ans = console >3 ans = télé
Réseaux sociaux	• Respect de sa vie privée personnelle et de celle des autres • régler les paramètres de confidentialité • sécurité des profils : ◦ effacer cookies ◦ ne pas rester connecté • données privées • ttt soumis à la loi • RGPD : règlement général de préservation des données
Risques auditifs	• Exposition prolongée à de forts niveaux sonores • trauma sonore aigu Compression audio-dynamique : • homogénéise le niveau d'écoute • intensité maximale du son est atteinte plus fréquemment

MODULE 7 : VACCINATION

Histoire	Première vaccination : Edward Jenner 1796 inoculation de matériel provenant de pustule provoquée par la vaccine (poxvirus des vaches) → protection contre la variole Première atténuation : Pasteur 1885 → ère de la vaccination Joseph Meister mordu par un chien → ttt anti-rabique en post-expo d’une souche atténuée au labo 2016 : objectifs non atteints																	
Différents types de vaccins	<table><tr><th>Type de vaccin</th><th>Caractéristiques</th><th>Exemples</th></tr><tr><td>Vivant Atténué</td><td>Le micro-organisme est atténué, Il ne cause pas la maladie Il se réplique Il induit une réponse immune</td><td>Rougeole, oreillons, rubéole BCG Polio (oral) Fièvre jaune Varicelle</td></tr><tr><td>Entier Inactivé</td><td>Le micro-organisme est inactivé Il ne peut pas se répliquer Il induit une réponse immune</td><td>Coqueluche (1ère génération) Choléra (1ère génération) Fièvre typhoïde (1^{ère} génération)</td></tr><tr><td rowspan="2">Sous-unité / fractions</td><td>Composants du micro-organisme (protéines, polysaccharides, etc.).</td><td>H1B, coqueluche (2ère gén.), pneumocoques, méningocoques , grippe</td></tr><tr><td>Protéines du micro-organisme produites par génie génétique</td><td>Hépatite B , Papillomavirus</td></tr><tr><td>Antitoxines</td><td>Toxine détoxifiée = anatoxines</td><td>Diphtérie, tétanos</td></tr></table>	Type de vaccin	Caractéristiques	Exemples	Vivant Atténué	Le micro-organisme est atténué, Il ne cause pas la maladie Il se réplique Il induit une réponse immune	Rougeole, oreillons, rubéole BCG Polio (oral) Fièvre jaune Varicelle	Entier Inactivé	Le micro-organisme est inactivé Il ne peut pas se répliquer Il induit une réponse immune	Coqueluche (1ère génération) Choléra (1ère génération) Fièvre typhoïde (1 ^{ère} génération)	Sous-unité / fractions	Composants du micro-organisme (protéines, polysaccharides, etc.).	H1B, coqueluche (2ère gén.), pneumocoques, méningocoques , grippe	Protéines du micro-organisme produites par génie génétique	Hépatite B , Papillomavirus	Antitoxines	Toxine détoxifiée = anatoxines	Diphtérie, tétanos
Type de vaccin	Caractéristiques	Exemples																
Vivant Atténué	Le micro-organisme est atténué, Il ne cause pas la maladie Il se réplique Il induit une réponse immune	Rougeole, oreillons, rubéole BCG Polio (oral) Fièvre jaune Varicelle																
Entier Inactivé	Le micro-organisme est inactivé Il ne peut pas se répliquer Il induit une réponse immune	Coqueluche (1ère génération) Choléra (1ère génération) Fièvre typhoïde (1 ^{ère} génération)																
Sous-unité / fractions	Composants du micro-organisme (protéines, polysaccharides, etc.).	H1B, coqueluche (2ère gén.), pneumocoques, méningocoques , grippe																
	Protéines du micro-organisme produites par génie génétique	Hépatite B , Papillomavirus																
Antitoxines	Toxine détoxifiée = anatoxines	Diphtérie, tétanos																
Vaccins vivants	BCG Rougeole, oreillons, rubéole, Fièvre jaune, Varicelle, Polio buvable ▪ Souches naturelles (spontanément avirulentes) Ex : Virus bovin de la vaccine (variole éradiquée : plus utilisé) ▪ Souches vivantes atténuées (mutées) ▪ mutations au hasard : Procédé long et aléatoire Ex : BCG (Bacille de Calmette et Guérin) → Souche bovine <i>Mycobacterium tuberculosis</i> cultivée in vitro pendant 13 ans → Le BCG a perdu sa virulence et conserve des effets protecteurs contre la tuberculose ▪ Génie Génétique : Mutagenèse dirigée / gènes de pathogénicité Pas utilisés en médecine humaine																	
Vaccins inertes	▪ Vaccins inactivés entier ou sous-unités • Principe de l'inactivation + Par des agents physiques : chaleur, rayonnements ultraviolets + Par des agents chimiques : formol, bêta-propiolactone, éthylèneimine → traces possibles • Efficacité < vaccin vivant + Quantités importantes nécessaires + Adjuvant : ex vaccins anti-tétanique, anti-diphtérique																	

Généralités	• Efficacité des vaccins est hétérogène • Certains ont une efficacité très élevée : tétanos, diphtérie, hépatite A, hépatite B, rougeole • Certains ont une efficacité très intéressante mais moindre ◦ coqueluche : protection moins durable ◦ Pneumocoque : protection contre les principaux sérotypes, mais pas tous ◦ Grippe : efficacité plus ou moins élevée selon les années, parfois faible (<20%) ▪ dépend de la concordance entre souches vaccinales et souches circulantes pendant l'épidémie ◦ Tous les vaccins recommandés en Fce ont une efficacité suffisante pour motiver leur utilisation ▪ ce d'autant que les effets indésirables notables sont rarissimes
Poliomyélite	• Infection liée à la contamination des eaux et aliments par des déjections humaines • asymptomatique dans 90% des cas, et des symptômes digestifs dans 9% • Un tableau neurologique dans 1 % des cas : ◦ par atteinte de la corne antérieure de la moelle épinière ◦ responsable en aigu de paralysie (dont parfois les muscles respi) ◦ responsable ensuite de séquelles motrices
diphtérie	• Maladie très contagieuse • Gravité liée à plusieurs éléments ◦ l'angine à fausse mb (croup), à l'origine d'asphyxie ◦ sd retardés neurologiques et cardiaques • virulence particulièrement liée à la production d'une toxine • Effort au niveau mondial = haute couverture vaccinale et diminution des cas En Fce : depuis 2005 • souche bact historique : ◦ environ 2 cas par an ◦ presque tous à Mayotte ou importés • souche bact émergente ◦ origine animale ◦ 2 à 4 cas par an • Sujets en général non vaccinés ◦ ou dont la dernière vaccination remonte à plus de 30 ans
Coqueluche	• Une maladie G bénigne chez adulte (quoique des complications soient décrites chez le sujet âgé) • Potentiellement grave chez le nourrisson : risque asphyxique lors des quintes ◦ 15-30 % d'hospitalisation en soins intensifs ◦ Une des premières causes de mortalité du nourrisson d'origine infectieuse • Stratégie du cocooning : ne pas vacciner que les nourrissons mais également les personnes de leur entourage qui pourraient leur transmettre (fratrie, parents ...) • La disparition presque complète (polio, diphtérie) ou la raréfaction (coqueluche, infection Haemophilus influenza) de plusieurs des infections prévenues par le vaccin hexavalent ne doit pas inciter à diminuer la couverture vaccinale • C'est parce que la couverture vaccinale reste haute que ces maladies restent exceptionnelles
Rougeole	La rougeole dans le monde • Une des causes importantes de décès du jeune enfant, et donc l'objet d'un plan majeur de vaccination par l'OMS • En 2016, on a recensé 89 780 décès par rougeole dans le monde – C'est la première fois que ce nombre est inférieur à 100 000 par an • Grâce à la vaccination antirougeoleuse, les décès par rougeole dans le monde ont chuté de 84% entre 2000 et 2016. • En 2016, environ 85% des enfants dans le monde (contre 72% en 2000) ont reçu une dose de vaccin antirougeoleux avant l'âge de un an • Entre 2000 et 2016, on estime que la vaccination antirougeoleuse a évité 20,4 millions de décès La rougeole : une réputation induite de maladie toujours bénigne La plupart des cas de l'enfant se déroulent sans complications Celles-ci peuvent cependant survenir : – Otite (8%) – Pneumonie (5%) (mortalité : 5-30%) – Encéphalite aiguë (0,1%)(mortalité : 10%) – Panencéphalite sclérosante subaiguë (1/600 à

Cibles de la vaccination

Estimation de l'impact de la vaccination des adolescents de 11-16 ans entre 1994 et 2007

- Sont évitées annuellement ...
 - plus de 1000 hépatites aiguës
 - près de 3000 infections
 - plus de 100 à 300 infections chroniques
 - environ 5 hépatites fulminantes
- Ont été évitées depuis entre 1994 et 2007 environ ...
 - 8000 hépatites aiguës
 - 20 000 infections
 - 1000 à 2000 infections chroniques
 - 40 hépatites fulminantes
- Potentiel de doublement de l'impact de la vaccination par une augmentation de la couverture

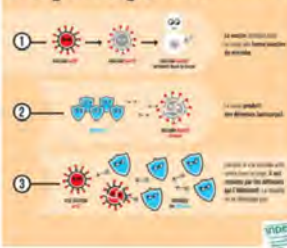
Sources : Institut de Veille Sanitaire

Les cibles de la vaccination

- Les nourrissons**
 - Les immuniser le plus tôt possible
 - Meilleur moyen d'éradiquer une maladie
 - 11 vaccins obligatoires en France
- Les voyageurs**
 - En fonction du pays de destination
- Les personnes ayant une maladie chronique**
 - Pour éviter que l'infection aggrave cette maladie
 - Grippe, pneumocoque ...
- Les immunodéprimés**
- Les soignants**
 - Pour leur éviter une infection transmise par les patients
 - Pour leur éviter de transmettre une infection aux patients
 - Hépatite B, varicelle (si négatifs), grippe ...
- Les personnes qui ont une vie sexuelle à risque**
 - Hépatite A, hépatite B, ...
- Tous les adolescents et adultes**
 - Rappel 11-13 ans, puis 25 ans, 45 ans, 65 ans, ...

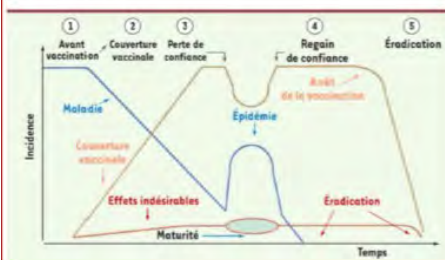
Fausses idées

Le principe de la vaccination



- Plus on s'entraîne meilleur on est → sport, musique ... vaccination
- mémoire immunitaire = mémoire photographique → reconnaissance plus rapide + armes adaptées
- On rencontre des milliers de microorganismes par jour
- Capacité immune d'un nourrisson : peut répondre à 10 000 vaccins simultanément
- Les 11 vaccins obligatoires n'occupent que 0,1% de ses lymphocytes

« le vaccin victime de son propre succès »



- Maladie parfois moins immunisante que vaccin (ex : tétanos)

Voici les risques encourus pour une immunité naturelle

TABLEAU II

Histories et mortalités attribuées aux États-Unis avant l'introduction d'une vaccination spécifique

Maladie	Cas cliniques	Séquences	Décès
Rougeole	200 000	300	250-400
Couque	400 000	40	200-300
Rubéole	300 000	750	10-15
Ostre	75 000	5	7-5
Hépatite B	25 000	2 000	1 000-1 500
Poliomyélite	140 000	2 500	100-400
Parvovirus B	5 000	1 500	200-400

- Séquences et décès = 1 pour 2,5 à 1 pour 9000
- A rapporter au seul événement indésirable grave qu'est l'anaphylaxie : 1/ pour 100 000 à 1 000 000

Les effets indésirables ou non voulus de la vaccination

- Les principaux = Désagréments mineurs
 - Fèvre peu élevée pendant quelques jours
 - Douleur au point d'injection
 - Eruption cutanée
- 1 événement indésirable grave reconnu : Anaphylaxie = 1/100 000, 1/1 000 000
- Comparer avec un autre risque :
 - Avoir un accident de voiture : 1/85
 - Être frappé par la foudre : 1/60 000
 - Être écrasé dans un tremblement de terre : 1/150 000
- Risque bien plus faibles que les risques liés à la maladie

Les sources d'aluminium dans notre environnement

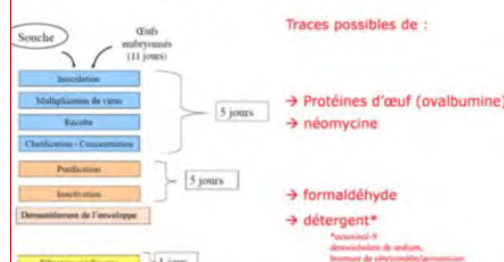
- Aliments : origine naturelle ou contamination par les ustensiles ou les emballages,
- Déodorants,
- Eau,
- Exposition professionnelle, accidentelle



- Tous les vaccins ne contiennent pas d'aluminium
 - Ex de vaccin qui en contiennent : vaccin anti-diphtérique, vaccin antitétanique
 - Ex de vaccin qui n'en contiennent pas : vaccin anti-grippal
- L'aluminium :
 - améliore l'efficacité des vaccins
 - diminue les effets indésirables
 - permet de réduire
 - Les concentrations d'Ag
 - Le nombre d'injections
- L'aluminium n'est toxique qu'à forte dose
 - Quantité d'aluminium par vaccin : 0,2-0,5 mg (max = 0,85 mg)
 - Apport journalier d'aluminium par VO : 3-5 mg

Les autres « produits chimiques »

Ex : Vaccin anti-grippal



Efficacité des vaccins



- L'efficacité à 100% n'existe pas
- Diminution des symptômes et des complications

Vaccin contre l'hépatite B / sclérose en plaques

Polemique franco-française

- Vaccination massive intervenue :**
 - à un âge où apparaissent les 1ers symptômes (adolescent/jeune adulte)
- à une époque où le diagnostic de la SEP a été nettement amélioré
- à une époque où SEP reconnue comme maladie longue durée

Un vaccin disculpé

Un vaccin disculpé !

Lancet (Fev 2000)
« Vaccin contre l'hépatite B n'a pas d'impact sur la survenue d'une sclérose en plaques »

Nature Medicine (Sept 1999)
« Dans aucune tranche d'âge, la vaccination n'augmente le risque de survenue d'affection démyélinisante »

La Presse Médicale (Avr 2000)
« Pas de relation causale entre les PCND, rapportées et une vaccination au préalable avec Genvac-B »

NEJM (Fev 2001)
« Absence d'association entre vaccination HB et survenue de SEP »

OMS (Oct 1988)
« La survenue de la vaccination ne se justifie pas sur le plan scientifique »

VHFD (Jui 1998)
« Pas d'association causale entre la vaccination contre l'hépatite B et les maladies démyélinisantes du SNC, y compris la SEP »

NEJM (Fev 2001)
« Pas de relation causale entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue de SEP »

- Probablement :
 - Comme toute entreprise
 - Traiter est plus lucratif que d'éradiquer
 - A qui profite la polémique anti-vaccination ?

Conclusion :

- Promouvoir la vaccination
- Auprès des indécis (pas des fanatiques)
- Expliquer simplement
- Lutter contre les idées reçues

SESA 2018-2019

ACTIVITÉS PHYSIQUES DANS UN OBJECTIF DE SANTÉ

SOMMAIRE

- ▶ Qu'est ce que l'activité physique (AP) ?
- ▶ Quelles sont les recommandations internationales ?
- ▶ Quels sont les bénéfices de l'AP ?
- ▶ Déterminants de la pratique d'AP
- ▶ Repères chez le public d'enfants et adolescents

DÉFINITIONS

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

« Tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques entraînant une **augmentation de la dépense énergétique** au-dessus du métabolisme de repos » (Caspersen et al., 1985)

Activité professionnelle, loisirs, EPS, vie courante...

L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

« Forme d'AP, planifiée, structurée, répétitive, dont le but est d'améliorer ou de maintenir les **capacités physiques** d'un individu. »
(Fox, Biddle & Boutcher, 2000)

LE SPORT

« AP qui implique des situations de compétition gouvernées par des **règles**, généralement dans un **cadre structuré**. »
(Fox, Biddle & Boutcher, 2000)

DÉFINITIONS (2)

LA CONDITION PHYSIQUE

Ensemble d'attributs (endurance, force, équilibre...) acquis ou atteignables qui sont en relation avec la **capacité de la personne à réaliser une activité physique.**

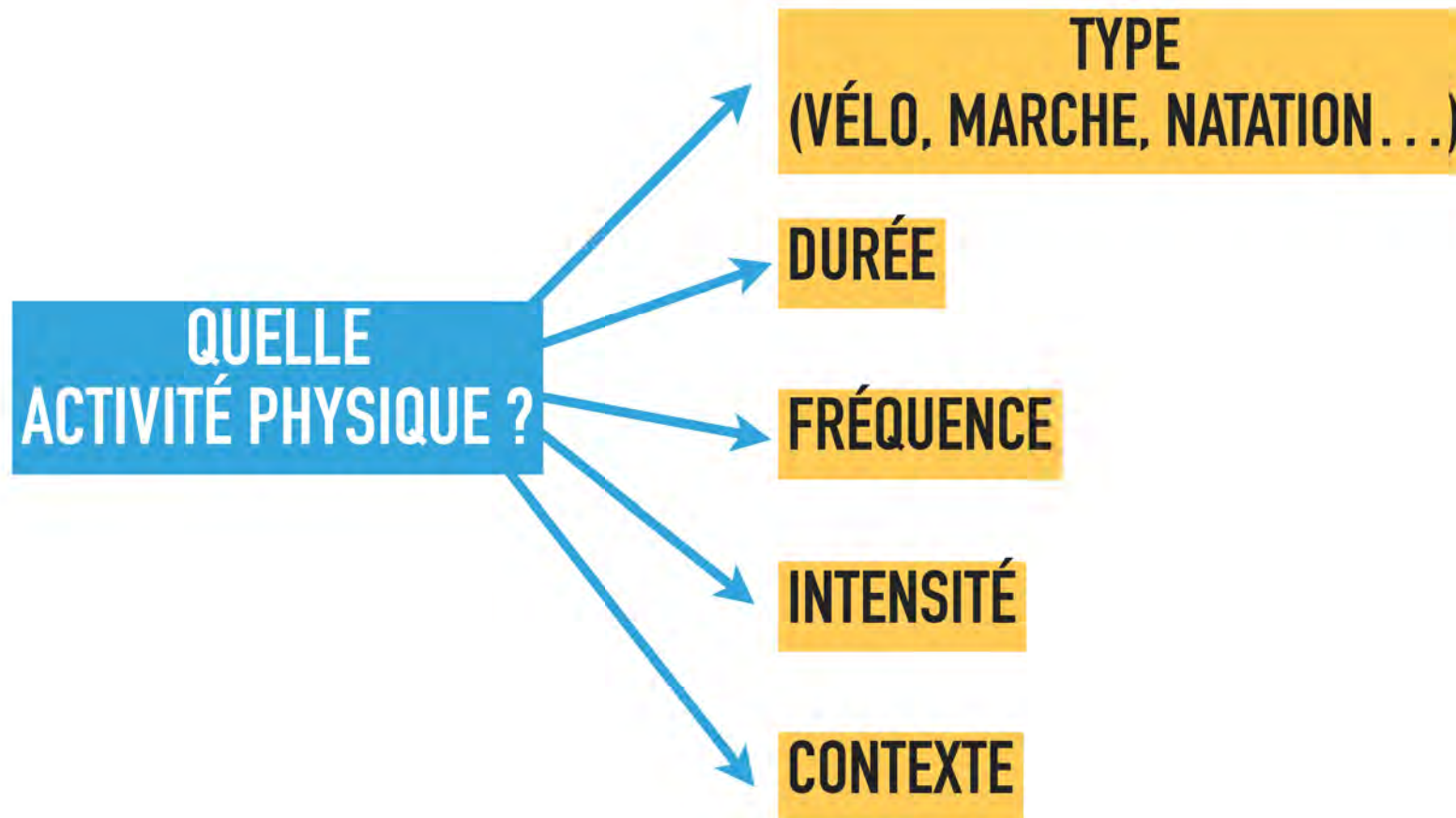
LA SÉDENTARITÉ

Niveau insuffisant d'activité physique (en particulier durant le temps libre) < **au seuil préconisé d'Activités physiques bénéfiques pour la santé.**

L'INACTIVITÉ PHYSIQUE

Participation à des activités spécifiques dont la dépense énergétique est proche de la **dépense de repos.**

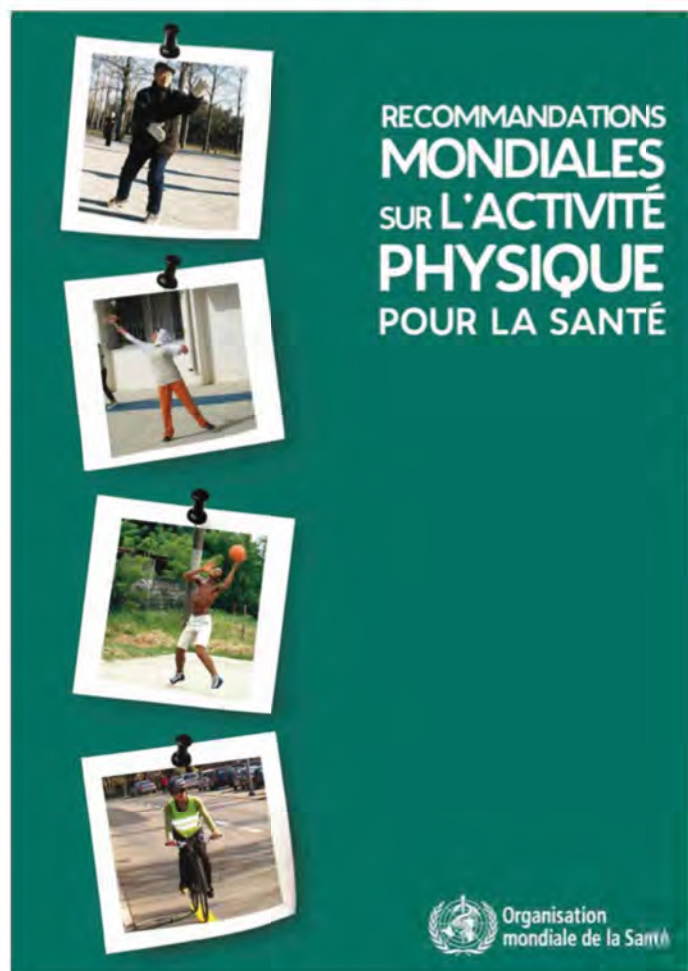
PRÉCISIONS À APPORTER POUR DÉCRIRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE



EN QUOI L'ACTIVITÉ PHYSIQUE EST-ELLE UN COMPORTEMENT DE SANTÉ ATYPIQUE ?

Activité physique	Autres comportement bénéfique pour la santé
Comportement d'adoption	Comportement de sevrage (tabac, drogues, alcool)
Décision qui doit être maintenue tout au long de la vie	Décision ponctuelle : « j'arrête »
Temps d'engagement plutôt long (durée d'AP)	Temps d'engagement plutôt court (ex : lavage de dents)
Comportement qui provoque des réactions affectives variables (fatigue, douleurs...)	Réactions affectives plutôt positives (bénéfices de l'arrêt du comportement nocif)

RÉFÉRENCES



<http://www.mangerbouger.fr/Les-9-reperes/Les-9-reperes-a-la-loupe/Activite-physique>



CHEZ L'ADULTE (OMS 2010)

- ▶ Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, **150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée** ou au moins **75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue**, ou une **combinaison** équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue
- ▶ L'activité devrait être pratiquée par périodes **d'au moins 10 min.**
- ▶ Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les adultes devraient augmenter la durée de leur activité d'endurance d'intensité modérée de façon à atteindre **300 minutes par semaine** ou pratiquer 150 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue.
- ▶ Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine par périodes d'au moins 10 min.

CHEZ L'ENFANT (OMS 2010)

- ▶ Les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins **60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue**.
- ▶ Le fait de pratiquer une activité physique pendant **plus de 60 minutes** apporte un bénéfice supplémentaire pour la santé.
- ▶ L'activité physique quotidienne devrait être essentiellement une **activité d'endurance**. Des activités d'intensité soutenue, notamment celles qui renforcent le système musculaire et l'état osseux, devraient être incorporées au moins trois fois par semaine.

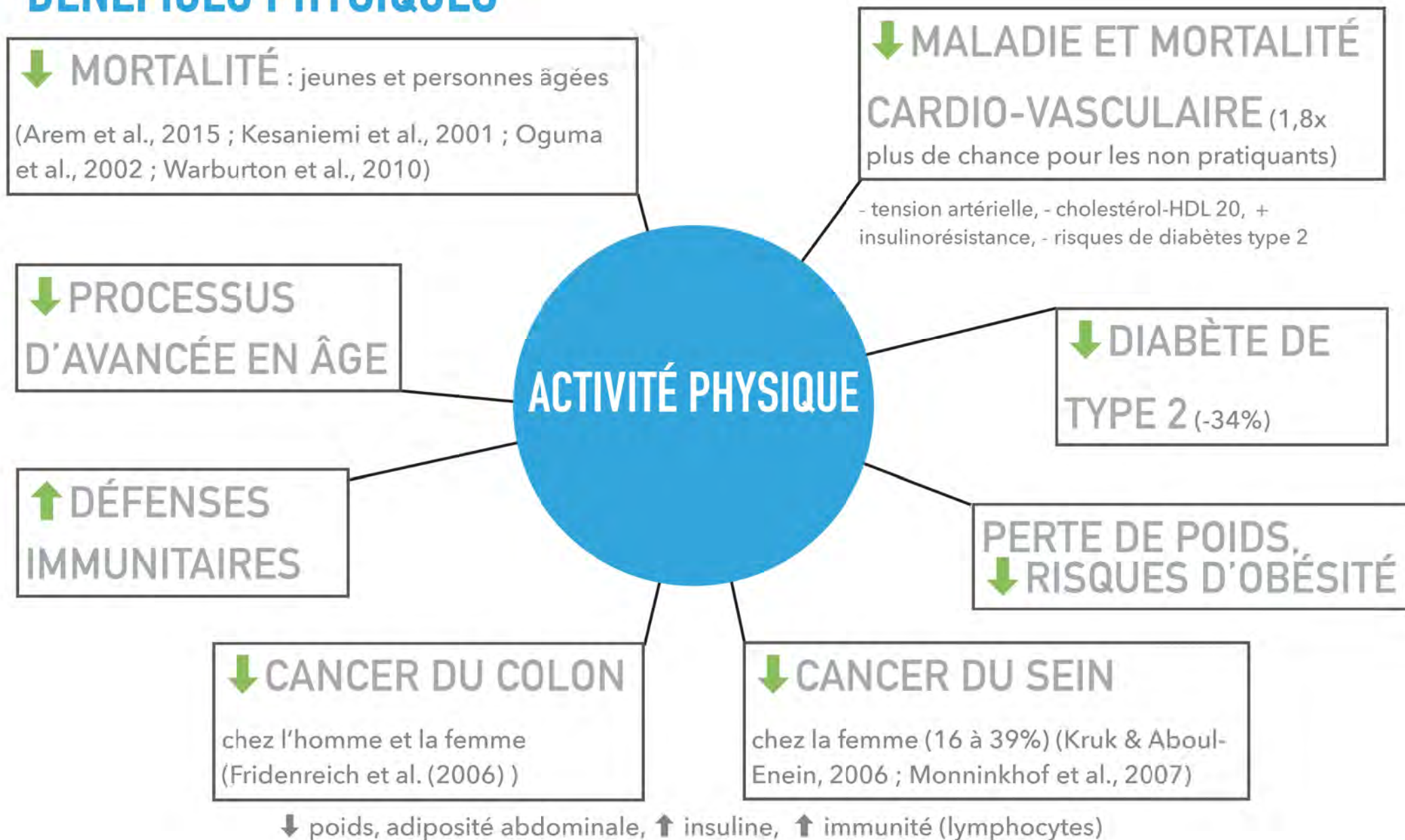
CHEZ L'ENFANT, EN D'AUTRES TERMES

- ▶ Une dose **minimale** de 300 minutes hebdomadaires (60 min x 5j) de marche à pied rapide pour les enfants en âge d'être scolarisés.
- ▶ éviter les plages horaires de sédentarité supérieures à 2h
- ▶ En nombre de pas : **entre 10.000 et 12000 pas** pour un adolescent (Guinouiha 2010)

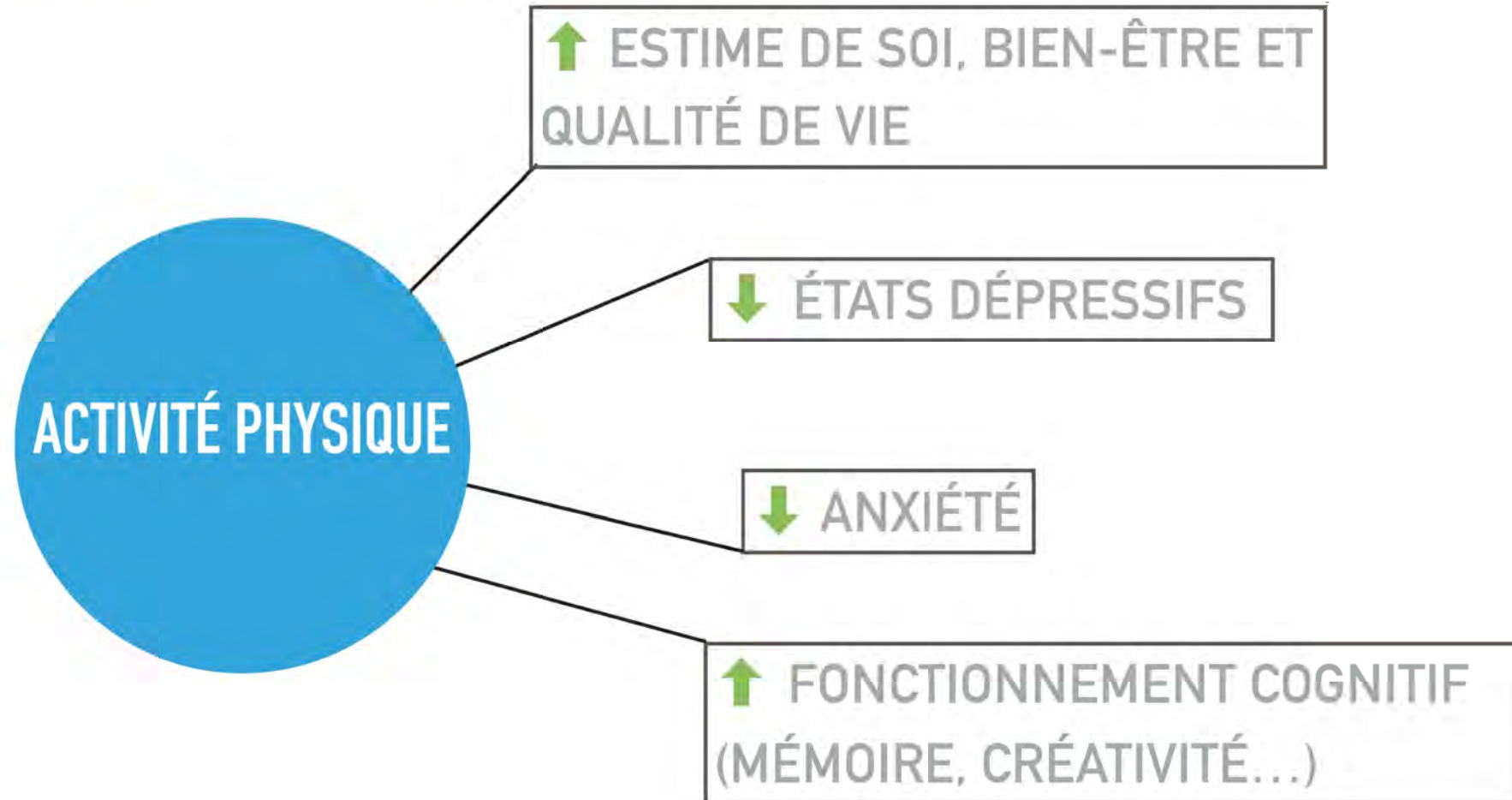
L'AP RÉGULIÈRE EST UN MOYEN DE PRÉVENTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE EFFICACE POUR PLUS DE 25 CONDITIONS MÉDICALES CHRONIQUES ET LA MORTALITÉ PRÉMATURÉE.

(Warburton et al., 2006, 2010, Pedersen et al., 2015).

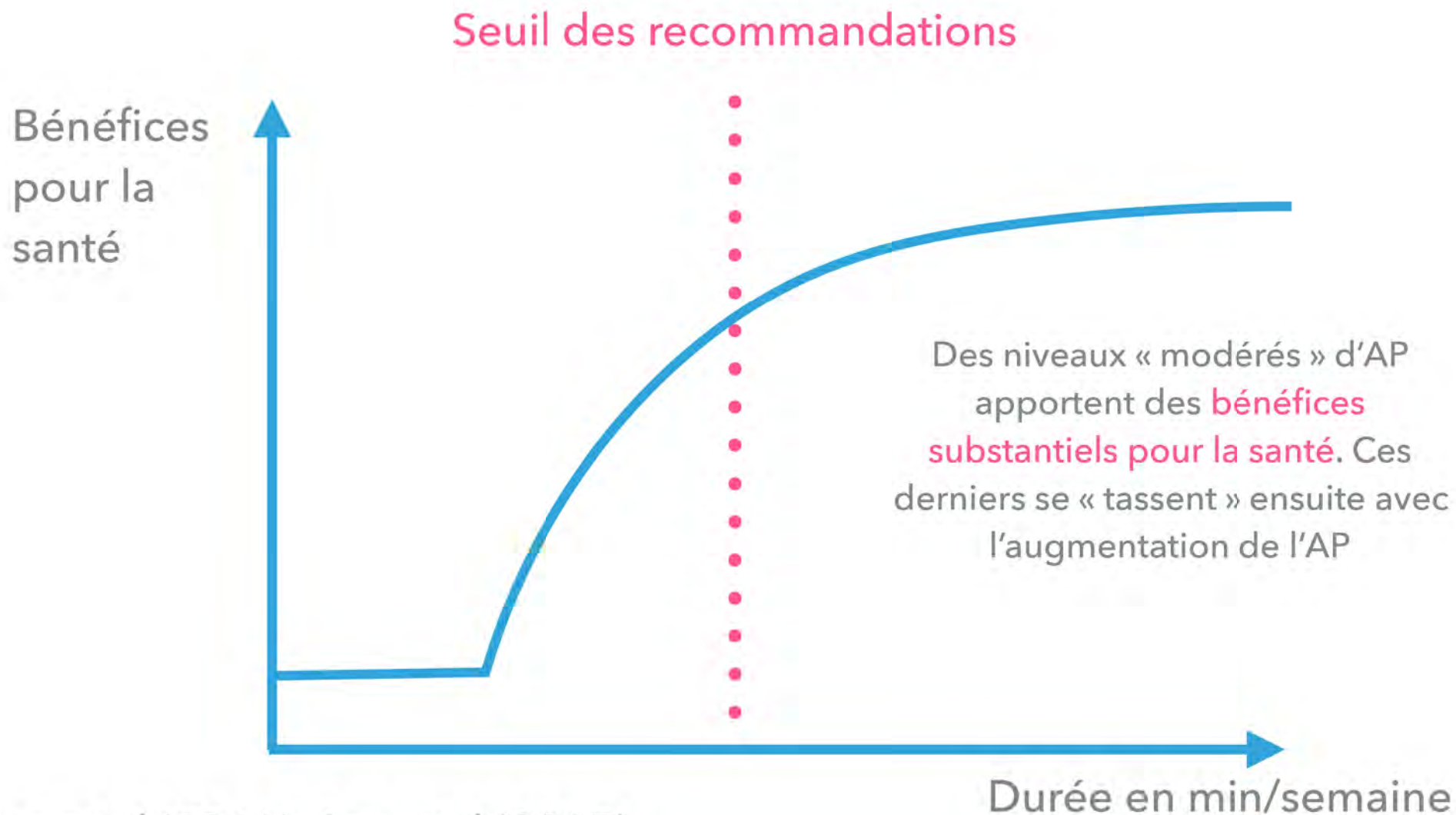
BÉNÉFICES PHYSIQUES



BÉNÉFICES PSYCHOLOGIQUES

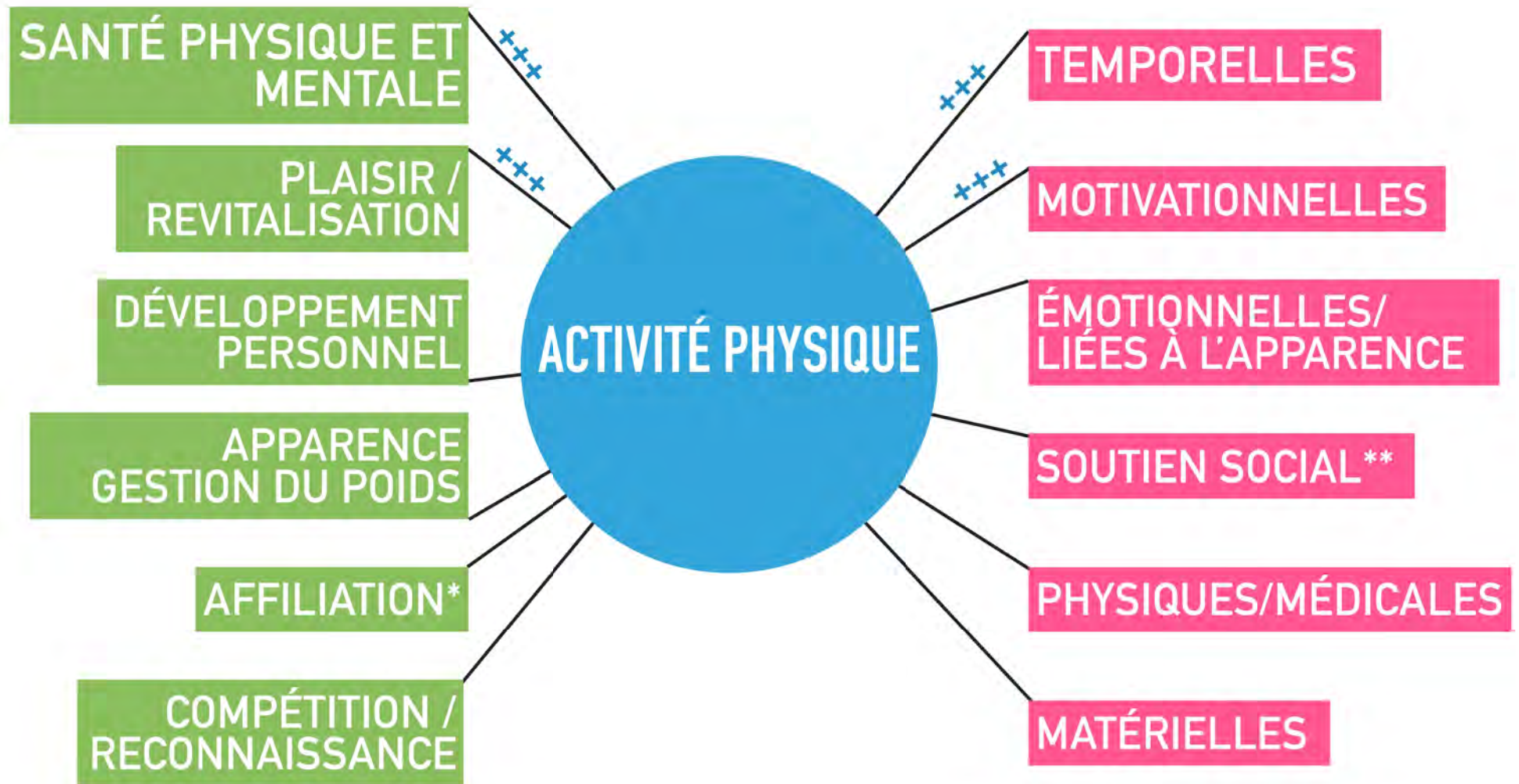


RELATION EFFET-DOSE



Wen et al (2011), Are et al (2015)

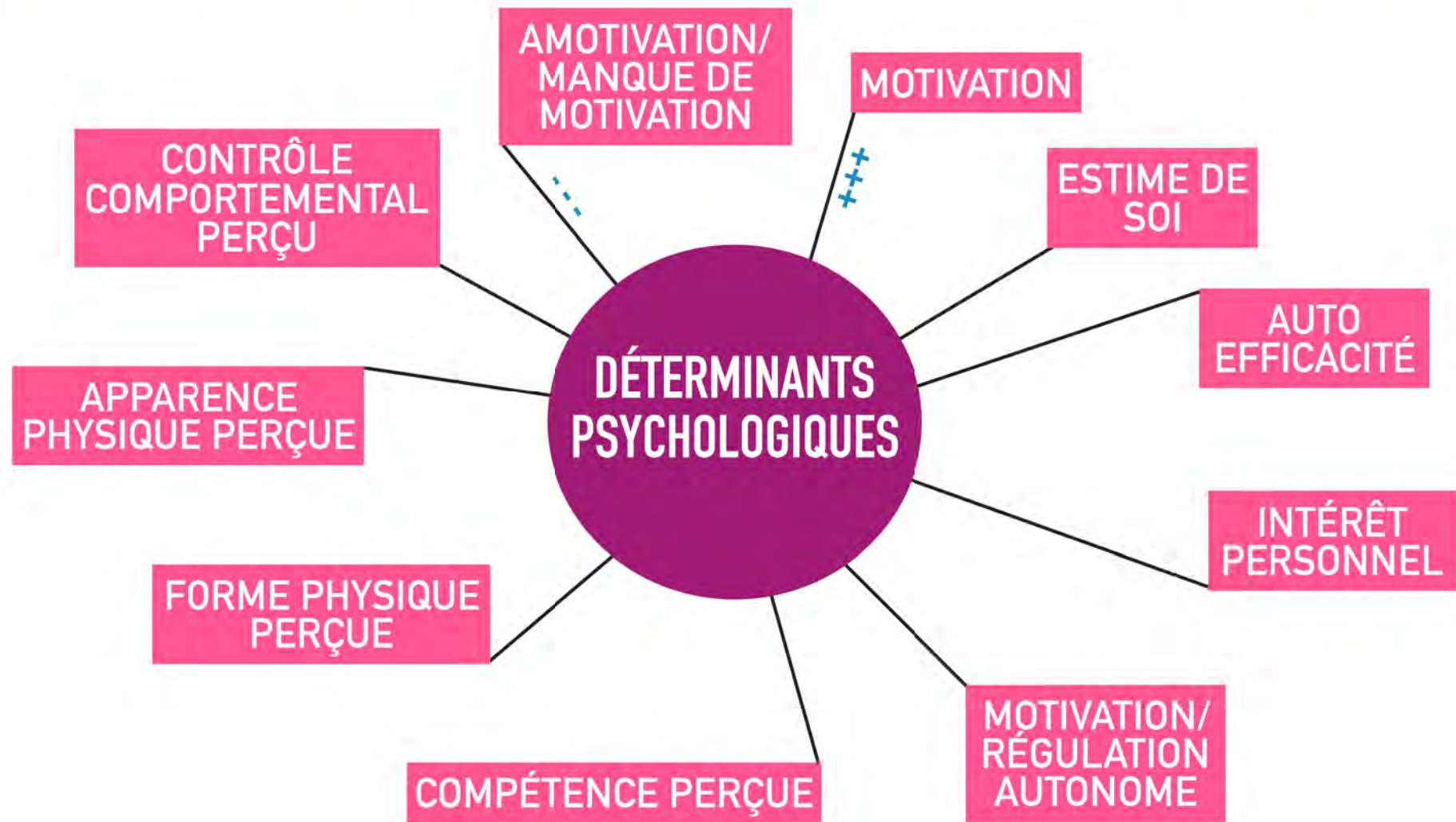
SOURCES DE MOTIVATION VS OBSTACLES À LA PRATIQUE



* Je pratique de l'AP car je m'identifie comme étant un « sportif »

** Manque de personnes avec qui pratiquer, pas de soutien familial, relationnel

RÉSULTATS DE « DETERMINANTS OF DIET AND PHYSICAL ACTIVITY » (CORTIS&AL 2017)



RÉSULTATS DE « DETERMINANTS OF DIET AND PHYSICAL ACTIVITY » (CONDELLO&AL 2017)

CORRÉLÉS POSITIVEMENT

SPORT À L'ÉCOLE

NIVEAU
D'ACTIVITÉ
PRÉCÉDENT

MOBILITÉ
INDÉPENDANTE
ET TRANSPORT
ACTIF

DÉTERMINANTS
COMPORTEMENTAUX

CORRÉLÉS NÉGATIVEMENT

USAGE
D'INTERNET

LECTURE

AUTRES
COMPORTEMENTS
SÉDENTAIRES

ACTIVITÉ
« VIGOUREUSE »*

* Plus l'activité pratiquée est vigoureuse, plus la quantité totale effectuée est faible

UN EFFONDREMENT DE LA PRATIQUE DE L'AP À L'ADOLESCENCE

- ▶ Entre l'enfance et l'adolescence, la pratique d'AP chute de **7% par an en moyenne**.
- ▶ Au total, c'est une chute de **60 à 70% durant l'adolescence** (entre 8-9 ans et 18-19 ans) (Dumith 2011)
- ▶ Ce déclin est plus marqué chez les filles entre 9 et 12 ans alors qu'il l'est entre 13 et 16 ans pour les garçons.

DÉFINITION DES « NIVEAUX D'ACTIVITÉ PHYSIQUE » (NAP)

niveau « élevé »	- pratique d'une AP modérée ou intense tous les jours ou; - pratique d'une AP intense au moins cinq fois par semaine
niveau « faible »	- pratique d'une AP modérée ou intense au moins cinq fois par semaine ou; - pratique d'une AP intense moins de trois fois par semaine
niveau « modéré »	toute autre situation intermédiaire

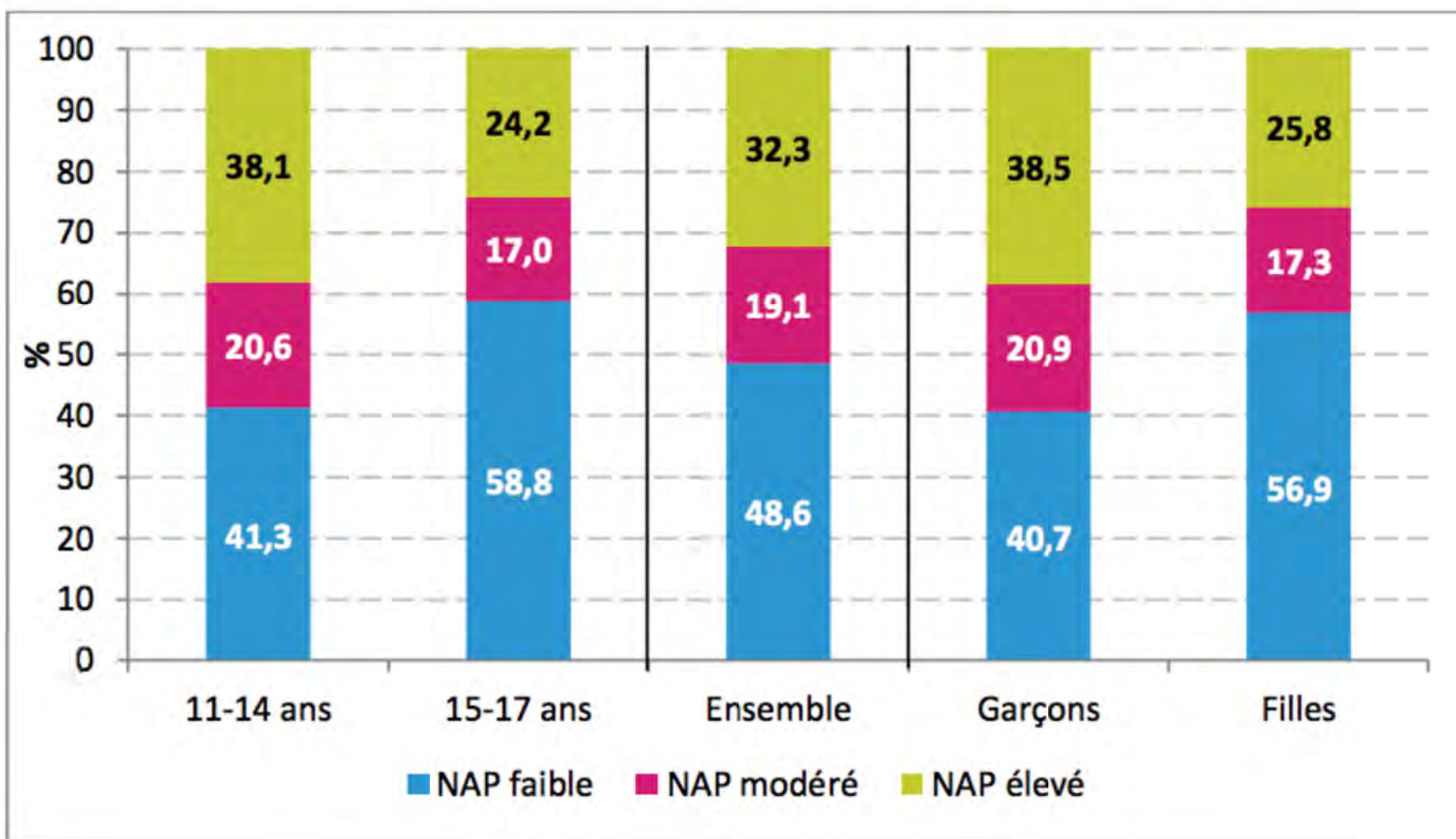
AP « MODÉRÉE »

Pratique physique pendant au moins 60 minutes consécutives, de façon peu intense, qui n'a fait ni transpirer, ni respirer plus difficilement que normalement.

AP « INTENSE »

Pratique physique pendant au moins 40 minutes consécutives, qui a fait transpirer et respirer plus difficilement que normalement.

REPARTITION DES NIVEAUX D'ACTIVITÉ PHYSIQUE DES ADOLESCENTS (11-17 ANS) SELON L'ÂGE ET LE SEXE.



Source : Étude INCA3, 2014-2015, traitement Anses

SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DES ADOS (11-17ANS) (ONAPS 2017)

- ▶ **12% des adolescents** âgés de 11 à 14 ans déclarent suivre les recommandations actuelles (une heure d'activité physique au moins modérée par jour).
- ▶ **31% pratiquent au moins 1 heure par jour** d'activité physique au moins 5 jours par semaine.
- ▶ À cet âge, les différences entre les sexes commencent à se marquer.
- ▶ La fréquence de la pratique diminue avec l'âge.
- ▶ Il y a des différences de fréquence de pratique selon les régions.
- ▶ Deux tiers des collégiens ont eu au moins deux cours d'éducation physique au collège la semaine précédant l'enquête.
- ▶ Deux tiers des collégiens pratiquent un sport en dehors de l'école.

SUR LA SÉDENTARITÉ (3-17 ANS) (ONAPS 2017)

- ▶ La durée moyenne passée devant un écran par les enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans est d'environ **trois heures par jour**, chez les garçons comme chez les filles.
- ▶ Cette durée moyenne augmente avec l'âge, de façon plus marquée chez les garçons et avec une contribution de plus en plus importante du temps passé devant un ordinateur.
- ▶ La proportion d'enfants et d'adolescents passant plus de trois heures par jour devant un écran est d'environ **40%**.
- ▶ Un collégien sur 9 passe plus de deux heures par jour devant un écran.
- ▶ La durée passée devant un écran est en moyenne plus importante au nord de la France qu'au sud, essentiellement en raison du temps passé devant la télévision.
- ▶ Près de 23% des enfants scolarisés en grande section de maternelle ont un écran dans leur chambre. Le temps de sommeil diminue quand le temps passé devant un écran est plus élevé.